HISTORIA CLÍNICA

NOTAS MÉDICAS

Fecha: 10/02/2025 22:27 - Ubicación: ADMISION Y SALA DE PARTOS
Nota de antecedentes - GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Ginecológicos y obstétricos:
Se adiciona(n) el antecedente:
GINECOLÓGICOS

OBSTÉTRICOS
Gestaciones:
Materna Gesta actual: 1

Fecha: 10/02/2025 22:27 - Ubicación: ADMISION Y SALA DE PARTOS
Ingreso a servicio de obstetricia - GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Clasificación del triage: TRIAGE III Causa externa: ENFERMEDAD GENERAL

Condiciones del paciente: Materna

Gesta: 1
Peso(Kg): 53
ANAMNESIS
Motivo de consulta: "ME MANDARON"
Enfermedad actual: DEBY CORTES, 20 AÑOS, UNION LIBRE, RESIDENTE EN LOS LAGOS, CALI, TRABAJA EN COCINA, BACHILLERATO COMPLETO, O+

EA:
PACIENTE 20 AÑOS, G1P0, EMBARAZO DE 23. 4 SS POR ECOGRAFIA 12/11/24 PARA 10. 5 SS, QUIEN REFIERE CUADRO CLINICO DE 2 MESES DE EVOLUCIÓN DE DISMINUCIÓN CLASE FUNCIONAL, ASOCIADO A DISNEA DE PEQUEÑOS ESFUERZOS, ORTOPENA, NIEGA EDEMA MMII, EL DIA DE HOY CONSULTA POR AUMENTO SENSACION DE PALPITACIONES Y DISNEA A CENTRO PRIMER NIVEL, SEGUN HC REALIZAN RX TÓRAX EN LA QUE SE OBSERVA CONGESTION PARAHILIAR, INFILTRADOS PARAHILIARES, NO DERRAME NI MASAS, IC <0. 5, SOPLO CARDIACO POR LO QUE REMITEN PARA VALORACIÓN.
PACIENTE NIEGA SINTOMAS DE BAJO GASTO, NIEGA PERDIDAS VAGINALES, NIEGA PREMONITORIOS, NIEGA ACTIVIDAD UTERINA, SIENTE MOVER A SU BEBE.
CONSUMO ACIDO FOLICO, CALCIO, NO SULFATO FERROSO.

10/02/25: TSH 2. 23, T4L: 1. 28, HB: 11. 3

EMBARAZO ACTUAL: HA REALIZADO 6 CPN, INICIO A LAS 10. 5 SS, PESO INICIAL52 KG, PESO ACTUAL: 53KG, GANANCIA DE 1 KG, CIFRAS TENSIONALES NORMALES
VALORADA POR PSICOLOGIA, TRABAJO SOCIAL, NUTRICIÓN Y ODONTOLOGIA
VACUNACION PENDIENTE TDAP, COVID. INFLUENZA YA
PARACLINICOS.
19/11/24: HB: 14. 2, PLAQ: 223000, O+, CICLAJE NEGATIVO, AGSHB NEG, TOXO IGM NEGATIVO, IGG POSITIVO, RUBEOLA IGM NEGATIVO, IGGPOSITIVO, FV VAGINOSIS (TRATADO METRONIDAZOL), GLUCOSA 95
13/12/24: GLUCOSA PRE 96, POST 68, HBA1C: 4. 75%
14/01/25: VIH Y SEROLOGIA NEGATIVOS.
20/01/25: HB: 10. 6, HTO: 36, PLAQ: 210000

ECOGRAFIA:
22/01/25: 20. 6 SS, PFE: 316 GR, P. - 25-50, CEFALICO, PLACENTA POSTERIOR Y FUNDICA, ILA 14
-25/11/24: 12. 2 SS, SN 0. 9, HN PRESENTE
-12/11/24: 10. 5 SS

ANTECEDENTES.

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	

NOTAS MÉDICAS

-PATOLÓGICOS: ANEMIA
-FARMACOLÓGICOS: NIEGA
-ALERGICOS: NIEGA
-QUIRÚRGICOS: NIEGA
-TÓXICOS: NIEGA
-FAMILIARES: MADRE Y HERMANAS DIABETES
G/O: G1P0, FUM NO RECUERDA, CICLOS IRREGULARES, MENARCA 15 AÑOS. CITOLOGIA 20/11/24 NEGATIVA

EXAMEN FISICO:
BUENAS CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, CONJUNTIVAS PALIDAS, ROSADAS
PA: 122/65 MMHG, PULSO: 96 SAO2: 100% AMBIENTE, T. 36. 1, FR: 35 FCF: 148
C/P RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, MV CONSERVADO SIN SOBREAGREGADOS
ABDOMEN UTERO GRAVIDO, AU: 22 CM, FUVCDI, MOVIMIENTOS FETALES PRESENTES, NO ACTIVIDAD UTERINA, NO DOLOR
G/U SIN SANGRADO, SE OMITE TV
LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS. LLAMA LA ATENCIÓN MACULAS HIPERCROMICAS EN DEDOS DE LAS MANOS.

REVISIÓN POR SISTEMAS
Revisión Física:
Sistema neurológico: Normal

EXAMEN FÍSICO
Talla(cm): 152 Superficie corporal(m2): 1. 5 Índice de masa corporal(Kg/m2): 22. 94 [Valores de referencia: Normal 18. 5-24. 9]

Examen Físico:
Aspecto general
Aspecto general : Normal.

Diagnósticos activos después de la nota R060 - DISNEA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, R074 - DOLOR EN EL PECHO NO ESPECIFICADO (Resuelto), Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, Z358 - SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, Diagnóstico de ingreso - I519 - ENFERMEDAD CARDIACA NO ESPECIFICADA (En Estudio), Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses.

ANÁLISIS DEL CASO Y PLAN DE MANEJO

Análisis del caso: PACIENTE 20 AÑOS, G1P0, EMBARAZO DE 23. 4 SS POR ECOGRAFIA 12/11/24 PARA 10. 5 SS, CUADRO 2 MESES DE DISMINUCION CLASE FUNCIONAL, ASOCIADO A DISNEA Y ORTOPNEA, AL INGRESO PACIENTE CON TAQUIPNEA, SIN DESATURACIÓN, AUSCULTACION CARDIOPULMONAR NORMAL (SEGUN HC DE REMISIÓN SOPLO CARDIACO), NO AUSCULTABLE EN ESTE MOMENTO, EMBARAZO HASTA AHORA NORMAL A LA ESPERA DE ECOGRAFIA DE DETALLE ANATOMICA. TSH Y HB NORMAL.
SE INDICA VALORACION POR MEDICINA INTERNA, SE SS ECOTT, PROBNP Y SEGUN CONCEPTO DEFINIR NUEVAS CONDUCTAS.
POR OTRO LADO PACIENTE CON LESIONES EN MANO TIPO MACULAS HIPERCROMICAS, SE SOLICITA A MEDICINA INTERNA ENFASIS EN ESTE HALLAZGO
SE EXPLICA A LA PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

DIAGNÓSTICOS:
-G1P0
-EMBARAZO DE 23. 4 SS
-FUVC
-DISNEA EN ESTUDIO
Plan de manejo: OBSERVACION
DIETA LIBRE
TAPON HEPARINIZADO
SS PROBNP, CR, HEMOGRAMA, NA, K, CL, GASES ARTERIALES, ACIDO LACTICO
ECOTT
VALORACIÓN POR MEDICINA INTERNA.
VIGILAR SIGNOS VITALES, FCF
AVISAR CAMBIUOS, GRACIAS.

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	

NOTAS MÉDICAS

Nota aclaratoria

Fecha: 10/02/2025 22:52

SS EKG (YA REALIZADO) CON DII LARGO

Fecha: 11/02/2025 03:00 - Ubicación: ADMISION Y SALA DE PARTOS
Evolución médica - GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Condiciones del paciente: Materna
Gesta: 1

ANAMNESIS
Subjetivo:.
Objetivo:.

EXAMEN FÍSICO
Escala del dolor: 0.

Diagnósticos activos después de la nota Diagnóstico principal - I519 - ENFERMEDAD CARDIACA NO ESPECIFICADA (En Estudio), Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, R060 - DISNEA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, Z358 - SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses.

ANÁLISIS DEL CASO Y PLAN DE MANEJO

Análisis:.

Plan de manejo:.

Justificación de permanencia en el servicio:.

--REGISTRO PENDIENTE DE AVAL--

Fecha: 11/02/2025 03:06 - Ubicación: ADMISION Y SALA DE PARTOS
Evolución médica - Interconsultante - MEDICINA INTERNA

Tipo de evolución: Evolución adicional
Causa externa: ENFERMEDAD GENERAL

Condiciones del paciente: Materna
Gesta: 1

ANAMNESIS

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	

NOTAS MÉDICAS

*** Motivo de interconsulta: "Signos de falla cardiaca"

*** Enfermedad actual: Paciente femenina de 20 años de edad con cuadro clínico de 2 meses de evolución, consistente en disnea de pequeños esfuerzos, ortopnea, niega edema mmii, el día de hoy remitida de consulta externa por aumento sensación de palpitaciones y disnea. Refiere que ha requerido en múltiples ocasiones consulta por disnea.

*** Antecedentes:
Patológicos: Anemia durante la gestacion
Farmacológicos: NIega
Alérgicos: Niega
Quirúrgicos: Niega
Tóxicos: Niega
Inmunizaciones: Niega
Ginecológicos: G1A0V0

Objetivo: Signos vitales:
Frecuencia cardiaca: 95 Lpm
Frecuencia respiratoria: 16 Rpm
Tensión arterial: 102/54/ Mmhg
Temperatura: 36. 4°C
Saturación de oxígeno: 99 % (FiO2: %)

Examen físico:
Alerta, orientada en las tres esferas,
- Cabeza: Escleras anictéricas, mucosas rosadas e hidratadas
- Cuello sin masas ni adenopatías, ingurgitación yugular grado I, reflujo hepatoyugular negativo.
- Tórax: Ruidos cardiacos rítmicos, no soplos. Pulmones ventilados, sin ruidos agregados.
- Abdomen blando, sin dolor, globoso.
- Extremidades edemas miembros inferiores grado i, pulsos ++.
- Neurológico: Sin déficit.

Laboratorios:
ECG: FC: 65 lpm, ritmo sinusal, eje 30°, pobre progresión de la onda R,
.

EXAMEN FÍSICO
Escala del dolor: 0

Examen Físico:
Aspecto general
Aspecto general : Normal.

Diagnósticos activos después de la nota Diagnóstico principal - I519 - ENFERMEDAD CARDIACA NO ESPECIFICADA (En Estudio), Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, R060 - DISNEA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, Z358 - SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses.

ANÁLISIS DEL CASO Y PLAN DE MANEJO

Análisis: Paciente femenina de 20 años sin antecedentes patológicos, ahora en gestación en segundo trimestre, quien ha consultado en repetidas ocasiones por disnea. Refiere que la disnea aumenta en bipedestación, edema de miembros inferiores ocasionales y en ocasiones ortopnea por lo que no se descarta falla cardiaca. Al ingreso con signos vitales normales, sin agregados a la auscultación pulmonar, sin soplos, edema de miembros inferiores leve e ingurgitación yugular grado I, sin signos de dificultad respiratoria. ECG con pobre progresión de la onda R, sin otros hallazgos anormales. Última hb en 11. Dado que la disnea se ha presentado de manera frecuente se considera requiere estudio de etiologías distintas a los cambios fisiológicos generados por el embarazo. Se hará revaloración con resultados.

Diagnósticos:
1. Disnea en estudio
2. G1P0 - semana 23

Plan de manejo: Se solicita: pro bnp, ecocardiograma, bun, creatinina, uroanálisis, tsh, sodio, potasio, calcio, hemograma
Revalorar con resultados.

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	

NOTAS MÉDICAS

Justificación de permanencia en el servicio:.

Fecha: 11/02/2025 20:44 - Ubicación: ADMISION Y SALA DE PARTOS
Evolución médica - GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Condiciones del paciente: Materna
Gesta: 1

ANAMNESIS
Subjetivo: ** DIAGNOSTICOS
1. G1P0
2. EMBARAZO DE 23. 5 SEMANAS POR ECOGRFIA 12/11/2024 10. 5
3. DISNEA
3. 1 ESTENOSIS MITRAL SEVERA DE ORIGEN REUMATICO

**SUBJETIVO: PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN, NO DOLOR TORACICO, NO DISNEA EN REPOSO, NIEGA ACTIVIDAD UTERINA, NIEGA PERDIDAS VAGINALES, NIEGA OTROS SINTOMAS
Objetivo: PACIENTE EN SALA DE OBSERVACION SIN ACMPAÑANTE EN APARENTES BUENAS CONDICIONES GENERÑAES

EXAMEN FÍSICO
Presión arterial (mmHg): 102/70, Presión arterial media(mmhg): 80
Frecuencia cardíaca(Lat/min): 63 Frecuencia respiratoria(Respi/min): 20
Saturación de oxígeno: 96%
Escala del dolor: 0

Examen Físico:
Tórax
Corazón : RSCS RITMICOS SIN SOPLOS
Pulmones : RSRS SIN AGREGADOS
Abdomen
Abdomen : NO SE PALPA ACTIVIDAD UTERINA
FCF 136 LPM
Genitales
Tacto vaginal : SIN SANGRADO

RESULTADOS PARACLÍNICOS
Análisis de resultados :2025-02-11 ECOCARDIOGRAMA
. VENTRÍCULO IZQUIERDO DE DIMENSIONES NORMALES, CON FUNCIÓN SISTÓLICA PRESERVADA (FEVI 65%).
· FUNCIÓN DIASTÓLICA NO VALORABLE.
· SIN TRASTORNOS SEGMENTARIOS DE LA CONTRACTILIDAD NI GRADIENTE OBSTRUCTIVO EN EL TRACTO DE SALIDA.
· VENTRÍCULO DERECHO DE TAMAÑO Y FUNCIÓN NORMAL.
· AURÍCULA IZQUIERDA SEVERAMENTE DILATADA, AURÍCULA DERECHA DILATADA
· ESTENOSIS MITRAL SEVERA DE ORIGEN REUMÁTICO
· PROBABILIDAD ALTA PARA HIPERTENSIÓN PULMONAR

HEMOGRMA AL 9. 320 N 63% HB 11. 1 HTO 35 PLT 231. 000
CREATININA 0. 5 BUN 6. 4
UROANALISIS CONTAMINADO
TSH 433
PROBNP 477
CL 101. 8
K 3. 61 NA 136. 2.

Diagnósticos activos después de la nota Diagnóstico principal - I519 - ENFERMEDAD CARDIACA NO ESPECIFICADA (En Estudio), Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, R060 - DISNEA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, Z358 - SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses.

ANÁLISIS DEL CASO Y PLAN DE MANEJO

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	

NOTAS MÉDICAS

Análisis: PACIENTE DE 20 AÑOS G1P0 CON EMABARZO DE 23. 5 SEMANAS, CON DIAGNOSTICOS:
1. DISNEA EN ESTUDIO DE DOS MESES DE EVOLUCION, CON ECOCARDIOGRAMA DONDE SE EVIDENCIA ESTENOSIS MITRAL SEVERA DE ORIGEN REUMÁTICO CON PROBABILIDAD ALTA PARA HIPERTENSIÓN PULMONAR; EN EL MOMENTO EN APARENTES BUENAS CONDICIONES GENERALES, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, SIGNOS VITALES NORMALES, CUENTA CON DEMAS PARACLINICOS DENTRO DE LA NORMALIDAD, SE DECIDE HOSPITALIZAR, SE SOLICITA VALORACION POR CARDIOLOGIA, SEGUN EVOLUCION SE DEFINIRAN CONDUCTAS ADICIONALES, SE EXPLICA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTIENDE Y ACEPTA

Plan de manejo: TRASLADO ARO I
DIETA COMUN
CONTROL DE SIGNOS VITALES AVISAR CAMBIOS
SE SOLICITA: VALORACION POR CARDIOLOGIA

Justificación de permanencia en el servicio: GESTANTE CON ENFERMEDAD CARDIACA EN ESTUDIO.

Fecha: 12/02/2025 09:16 - Ubicación: ADMISION Y SALA DE PARTOS
Evolución médica - GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Condiciones del paciente: Materna
Gesta: 1

ANAMNESIS
Subjetivo: SE ABRE FOLIO PARA CARGAR ECOGRAFIA OSTETRICA DE DETALLE ANATOMICO
Objetivo:.

EXAMEN FÍSICO
Escala del dolor: No aplica.

Diagnósticos activos después de la nota Diagnóstico principal - I519 - ENFERMEDAD CARDIACA NO ESPECIFICADA (En Estudio), Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, R060 - DISNEA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, Z358 - SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses.

ANÁLISIS DEL CASO Y PLAN DE MANEJO

Análisis:.

Plan de manejo:.

Justificación de permanencia en el servicio:.

--REGISTRO PENDIENTE DE AVAL--

Fecha: 12/02/2025 09:50 - Ubicación: ADMISION Y SALA DE PARTOS
Evolución médica - GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Condiciones del paciente: Materna
Gesta: 1

ANAMNESIS
Subjetivo: DEBY VANESA CORTES VILLARREAL
DIAGNO?STICOS
1. G1P0
2. EMBARAZO DE 23. 6 SEMANAS POR ECOGRAFÍA 12/11/2024 10. 5
3. DISNEA
3. 1 ESTENOSIS MITRAL SEVERA DE ORIGEN REUMÁTICO
4. BACTERIURIA ASINTOMÁTICA

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	

NOTAS MÉDICAS

SUBJETIVO
PACIENTE REFIERE SENTIRSE EN BIEN, NIEGA EPISODIOS DE DOLOR TORÁCICO, SIN DISNEA, BENDOPNEA, ORTOPNEA, TOLERANDO LA VÍA ORAL, DIURESIS Y DEPOSICIONES PRESENTES SIN ALTERACIONES, NIEGA PÉRDIDAS VAGINALES, SIN ACTIVIDAD UTERINA, NIEGA ALZAS TÉRMICAS.
Objetivo: PACIENTE SOLA, SIN ACOMPAÑANTE, LUCE EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, ALERTA, ORIENTADA, TRANQUILA, SIN SOPORTE DE OXÍGENO, ESTABLE

---PARACLI?NICOS-
11/02/2025 5:24
PEPTIDO ATRIAL NATRIURETICO: 416// TSH:4. 330//
BUN:6. 4// K:4. 21// NA:136. 2// CREA:0. 50

EUROANALYSIS: PATOLÓGICO

2:22
PEPTIDO ATRIAL NATRIURETICO: 477//
CL:101. 8// GLU:101//K:3. 61// NA:136. 3// CREA:0. 49
HEMOGRAMA LEU:9320//NEU:63. 4%// HB:11. 1// HTO:35. 4// VCM:86. 3// PQTS:231000
GASES: pH:7. 43// PCO2:33//PO2:87//SO2:97. 7//HCO3:21. 9// BE:-2. 0

EXAMEN FÍSICO--
SIGNOS VITALES: TA: 95/62 MMHG, // FC: 96 LPM, // FR: 20 RPM, // T°: 35. 8°C, // SO2: 96%
BUENAS CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, CONJUNTIVAS PÁLIDAS, ROSADAS
C/P RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS, MV CONSERVADO SIN SOBREAGREGADOS
ABDOMEN ÚTERO GRÁVIDO, AU: 22 CM, FUVCDI, MOVIMIENTOS FETALES PRESENTES, NO ACTIVIDAD UTERINA, NO DOLOR FCF: 145
G/U SIN SANGRADO, NO AMNIORREA, SE OMITE TV
LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS.

EXAMEN FÍSICO
Escala del dolor: No aplica

Examen Físico:
Aspecto general
Aspecto general : Normal.

Diagnósticos activos después de la nota Diagnóstico principal - I519 - ENFERMEDAD CARDIACA NO ESPECIFICADA (En Estudio), Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, R060 - DISNEA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, Z358 - SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses.

ANÁLISIS DEL CASO Y PLAN DE MANEJO

Análisis: PACIENTE DE 20 AÑOS G1P0 CON EMBARAZO DE 23. 6 SEMANAS, CON DIAGNÓSTICOS:

1. DISNEA EN ESTUDIO DE APROXIMADAMENTE DOS MESES DE EVOLUCIÓN, CUENTA CON ECOCARDIOGRAMA QUE EVIDENCIA ESTENOSIS MITRAL SEVERA DE ORIGEN REUMÁTICO CON ALTA PROBABILIDAD PARA HIPERTENSIÓN PULMONAR; CUENTA CON VALORACIÓN POR MEDICINA INTERNA QUE REFIEREN LEVE INGURGITACIÓN YUGULAR GRADO I, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA. ECG CON POBRE PROGRESIÓN DE LA ONDA R, SIN OTROS HALLAZGOS ANORMALES, DADO QUE DISNEA SE HA PRESENTADO DE MANERA FRECUENTE CONSIDERAN REQUIERE ESTUDIO DE ETIOLOGÍAS DISTINTAS A LOS CAMBIOS FISIOLÓGICOS GENERADOS POR EL EMBARAZO.

ACTUALMENTE PACIENTE SE ENCUENTRA CLÍNICAMENTE ESTABLE, NIEGA CEFALEA, SIN DISNEA, ORTOPNEA, NI SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, SIN EDEMA EN MIEMBROS INFERIORES, CUENTA CON PARACLÍNICOS DE CONTROL CON FUNCIÓN RENAL Y ELECTROLITOS EN RANGOS NORMALES, FUNCIÓN TIROIDEA NORMAL, PACIENTE CON DIAGNÓSTICOS ANOTADOS SE OFRECE LA POSIBILIDAD DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO POR PATOLOGÍA MATERNA, SE SOLICITA INTERCONSULTA POR PSICOLOGÍA.

UROANÁLISIS PATOLÓGICO ASINTOMÁTICA, SE CONSIDERA BACTERIURIA ASINTOMÁTICA SE INDICA CEFAZOLINA 1 GR EV CADA 6 HORAS. SE SOLICITA UROCULTIVO PREVIO AL INICIO DEL MANEJO ANTIBIÓTICO

SE CARGA ECOGRAFÍA DE DETALLE ANATÓMICO, A LA ESPERA DE SER VALORADA POR CARDIOLOGÍA, SEGÚN EVOLUCIÓN SE

NOTAS MÉDICAS

DEFINIRÁN NUEVAS CONDUCTAS.
SE EXPLICA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTIENDE Y ACEPTA

Plan de manejo: TRASLADO ARO I
DIETA COMÚN
CEFAZOLINA 1 GR EV CADA 6 HORAS
CONTROL DE SIGNOS VITALES AVISAR CAMBIOS
SE SOLICITA:
VALORACIÓN POR MEDICINA INTERNA
VALORACIÓN POR PSICOLOGÍA
ECOGRAFIA DE DETALLE ANATOMICO

+REALIZA MEDICO INTERNO DANIEL YELA UNIVALLE
+SUPERVISA DRA. MELISSA URIBE G/O UNIVALLE

Justificación de permanencia en el servicio:.

--REGISTRO PENDIENTE DE AVAL--

Fecha: 12/02/2025 11:32 - Ubicación: ADMISION Y SALA DE PARTOS
Evolución médica - Interconsultante - MEDICINA INTERNA

Tipo de evolución: Evolución adicional
Causa externa: ENFERMEDAD GENERAL

Condiciones del paciente: Materna
Gesta: 1

ANAMNESIS
Subjetivo: Deby Vanesa Cortes Villareal
Identificación: 1080832733
Edad: 20 Años
Aseguradora: Emssanar
Origen/Procedencia: Cali Valle del cauca
Fi HUV: 10/02/2025

Diagnósticos:
1. Estenosis mitral grave de origen reumático
1. 1 EcoTT: V. Max 2. 8m/s, GP: 32 mmHg, GM: 20 mmHg, AVM por VTI 1. 0cm2, THP 164 ms, AVM THP: 1. 3cm2
2. G1P0 - Embarazo de semana 23. 6 semanas
3. Bacteriuria asintomática
4. Hipotiroidismo subclínico a descartar

*** Antecedentes:
Patológicos: Anemia durante la gestacion
Farmacológicos: NIega
Alérgicos: Niega
Quirúrgicos: Niega
Tóxicos: Niega
Inmunizaciones: Niega
Ginecológicos: G1A0V0

Subjetivo:
Cuadro clínico de aproximadamente 2 meses de evolución, consistente en disnea de pequeños esfuerzos y ortopnea en ocasiones con sensación de palpitaciones. Niega dolor torácico, edema en miembros inferiores o síncope.
Objetivo: Examen físico
Paciente en buenas condiciones generales.

Signos vitales:
Frecuencia cardiaca: 98 Lpm

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	

NOTAS MÉDICAS

Frecuencia respiratoria: 20 Rpm
Tensión arterial: 100/60 mmHg
Temperatura: 36. 4°C
Saturación de oxígeno: 99 % (FiO2: %)

Examen físico:
- Cabeza: Escleras anictéricas, mucosas rosadas e hidratadas
- Cuello sin masas ni adenopatías, sin ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular negativo.
- Tórax: Ruidos cardiacos rítmicos, con soplo diastólico en foco mitral grado III/VI irradiado a foco aórtico. Pulmones ventilados, sin ruidos agregados.
- Abdomen blando, sin dolor, globoso.
- Extremidades sin edema en miembros inferiores, pulsos ++.
- Neurológico: Sin déficit.

Laboratorios:
11/02/2025 TARDE
PEPTIDO ATRIAL NATRIURETICO: 416, TSH:4. 3
BUN:6. 4, K:4. 21, NA:136. 2, CREA:0. 50
Uroanálisis con piuria y bacteriuria

11/02/2025 AM
PEPTIDO ATRIAL NATRIURETICO: 477
CL:101. 8 GLU:101 K:3. 61 NA:136. 3 CREA:0. 49
HEMOGRAMA LEU:9320 NEU:63. 4%HB:11. 1HTO:35. 4 VCM:86. 3// PQTS:231000
GASES: pH:7. 43 PCO2:33 PO2:87 SO2:97. 7 HCO3:21. 9 BE:-2. 0

Ayudas diagnósticas:
11/02/2025: ECO-TT:
VENA CAVA INFERIOR: Normal, con colapso inspiratorio mayor del 50%.
2. AURÍCULA DERECHA: Dilatada, sin observarse trombos en su interior.
3. VÁLVULA TRICÚSPIDE: Con adecuada implantación y movilidad de sus velos, insuficiencia tricúspidea leve fisiológica, sin estenosis, que permite cálculo de PSAP en 49mmHg.
4. VENTRÍCULO DERECHO: De tamaño normal, no hipertrófico, con función longitudinal preservada, sin trastornos de contractilidad.
5. VÁLVULA PULMONAR: sin insuficiencia. TAP: 94ms.
6. ARTERIA PULMONAR: Normales.
7. SÉPTUM INTERAURICULAR: Parece estar íntegro.
8. SÉPTUM INTERVENTRICULAR: Integro.
9. AURÍCULA IZQUIERDA: Severamente dilatada, sin trombos.
10. VÁLVULA MITRAL: Engrosamiento moderado de sus velos, El velo anterior presenta apertura en palo de jockey y el velo posterior esta restringido en su movimiento, condiciona una estenosis mitral severa (V. Max 2. 8m/s, GP: 32 mmHg, GM: 20 mmHg, AVM por VTI 1. 0cm2, THP 164 ms, AVM THP: 1. 3cm2). Sin insuficiencia. Aparato subvalvular con engrosamiento de las cuerdas tendinosas.
11. VENTRÍCULOIZQUIERDO: De forma y tamaño normal, con espesor normal. Los volúmenes ventriculares están preservados y la función sistólica normal (Fracción de eyección se calcula por el método volumétrico de Simpson Modificado 65%). No hay trastornos segmentarios de la contractilidad ni gradiente obstructivo en el tracto de salida. No se observan imágenes sugestivas de trombos intracavitarios evaluados por múltiples proyecciones. El flujo Doppler mitral sugiere función diastólica no valorable.
12. VÁLVULAAÓRTICA: De apariencia trivalva, adecuada coaptación de sus velos sin insuficiencia y sin estenosis. (V. max: 1. 5 m/seg, Gradiente pico: 9mmHg, VTI TSVI: 27cm)
13. AORTA: Raíz de la aórta y aórta ascendente no lucen dilatadas, con cayado aortico normal, aórta descendente sin coartación. Sin flujo diastólico reverso en la aórta descendente.
CONCLUSION:
Ventrículo izquierdo de dimensiones normales, con función sistólica preservada (FEVI 65%).
· Función diastólica no valorable.
· Sin trastornos segmentarios de la contractilidad ni gradiente obstructivo en el tracto de salida.
· Ventrículo derecho de tamaño y función normal.
· Aurícula izquierda severamente dilatada, Aurícula derecha dilatada
· Estenosis mitral severa de origen reumático
· Probabilidad alta para hipertensión pulmonar

11/02/2025: RADIOGRAFÍA DE TÓRAX FRENTE
Infiltrados intersticiales basales bilaterales.
No se observan nódulos, masas o áreas de consolidación en ambos campos pulmonares.
Tráquea y bronquios fuentes permeables.
Índice cardiotorácico conservado.

NOTAS MÉDICAS

Senos costofrénicos libres.

ECG: FC: 65 lpm, ritmo sinusal, eje 30°, pobre progresión de la onda R

EXAMEN FÍSICO
Frecuencia respiratoria(Respi/min): 20
Escala del dolor: 0.

Diagnósticos activos después de la nota Diagnóstico principal - I519 - ENFERMEDAD CARDIACA NO ESPECIFICADA (En Estudio), Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, R060 - DISNEA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, Z358 - SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses.

ANÁLISIS DEL CASO Y PLAN DE MANEJO

Análisis: Análisis:
Paciente de 20 años, primigestante con embarazo de 23. 6 semanas quien es redireccionada por cuadro de 2 meses de evolución consistente en deterioro progresivo de clase funcional sin angina, síncope ni edema en miembros inferiores, sin embargo, al ingreso documentaron edema grado 1 e ingurgitación yugular que al examen físico actual no se documenta. En ecocardiograma TT con FEVI preservada sin trastornos de la contractilidad pero se documenta estenosis mitral severa de origen reumático. En EKG sin fibrilación auricular y en examenes de laboratorio con proBNP elevado. Considero es prudente valoración por Cardiología para definir manejo quirúrgico de valvulopatía sintomática, actualmente sin congestión sistémica ni pulmonar para definir inicio de terapia diurética. Por cifras tensionales limitrofres que pueden explicarse por gestación, se difiere igualmente inicio de betabloqueador. No se documentó trombo auricular ni ha tenido eventos tromboembólicos previos, no se inicia anticoagulación.

Por TSH levemente fuera de metas, se ordena T4L ante posibilidad de hipotiroidismo subclínico.

Tiene bacteriuria asintomática, se sugiere realizar gram y urocultivo previo a manejo antibiótico con cefazolina.

Plan de manejo: Plan de manejo:
Se solicita T4L, gram de orina y urocultivo
Estimular deambulación
Valoración por Cardiología

Justificación de permanencia en el servicio: Estenosis mitral grave.

Fecha: 12/02/2025 12:09 - Ubicación: ADMISION Y SALA DE PARTOS
Evolución médica - Interconsultante - CARDIOLOGIA

Tipo de evolución: Evolución adicional
Causa externa: ENFERMEDAD GENERAL

Condiciones del paciente: Materna
Gesta: 1

ANAMNESIS

Motivo de interconsulta:
" Por estenosis mitral "

Enfermedad actual:
Paciente de 20 años, primigestante con embarazo de 23. 4 semanas, cuadro cli?nico de 2 meses de evolucio?n, consistente en disminución de la clase funcional con disnea de pequen~os esfuerzos, ortopnea, niega edema miembros inferiores.

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	

NOTAS MÉDICAS

Fue remitida de consulta externa por sensacio?n de palpitaciones, taquipnea y disnea.

Antecedentes:
Patológicos: Anemia gestacional.
Farmacológicos: Niega
Hospitalizaciones: Niega.
Quirúrgicos: Niega
Alérgicos Niega
Tóxicos: Niega.
Familiares: Niega

Objetivo: Examen físico:
Signos vitales:
PA: 100/54 mmHg FC: 106 lpm FR: 12 rpm T: 36, 3 ºC StO2: 93%
Cuello móvil, sin ingurgitación yugular.
Mucosas húmedas rosadas.
Tórax simétrico, normoexpansible.
Murmullo vesicular presente, sin crépitos.
Corazón rítmico, R1 reforzado con soplo mesodiastolico foco mitral
Abdomen con peristaltismo positivo, blando, depresible, útero grávido.
Extremidades móviles, sin edemas
Alerta, orientado, sin déficit.

Ayudas diagnósticas:
Laboratorios:
11/02/2025 Leu:9320 Neu:5910 Lin:177 Eos:1210 Plt:231000 Hb:11. 1 Hto:35. 4% VCM:86. 3 HCM:27. 1 Pro BNP:477 Glu:101 K:3. 61 Na:136. 3 Cl:101. 8 TSH:4. 33 ProBNP:416 Cr:0. 5 BUN:6. 4 K:4. 21 Na:136. 2

10/02/2025 ECG: FC: 65 lpm, ritmo sinusal, eje 30°, pobre progresio?n de la onda R.

Imágenes:
Ecocardiograma TT (11/02/25):
1. VENA CAVA INFERIOR: Normal, con colapso inspiratorio mayor del 50%. 2. AURÍCULA DERECHA: Dilatada, sin observarse trombos en su interior. 3. VÁLVULA TRICÚSPIDE: Con adecuada implantación y movilidad de sus velos, insuficiencia tricúspidea leve fisiológica, sin estenosis, que permite cálculo de PSAP en 49mmHg. 4. VENTRÍCULO DERECHO: De tamaño normal, no hipertrófico, con función longitudinal preservada, sin trastornos de contractilidad. 5. VÁLVULA PULMONAR: sin insuficiencia. TAP: 94ms. 6. ARTERIA PULMONAR: Normales. 7. SÉPTUM INTERAURICULAR: Parece estar íntegro. 8. SÉPTUM INTERVENTRICULAR: Integro. 9. AURÍCULA IZQUIERDA: Severamente dilatada, sin trombos. 10. VÁLVULA MITRAL: Engrosamiento moderado de sus velos, El velo anterior presenta apertura en palo de jockey y el velo posterior esta restringido en su movimiento, condiciona una estenosis mitral severa (V. Max 2. 8m/s, GP: 32 mmHg, GM: 20 mmHg, AVM por VTI 1. 0cm2, THP 164 ms, AVM THP: 1. 3cm2). Sin insuficiencia. Aparato subvalvular con engrosamiento de las cuerdas tendinosas. 11. VENTRÍCULOIZQUIERDO: De forma y tamaño normal, con espesor normal. Los volúmenes ventriculares están preservados y la función sistólica normal (Fracción de eyección se calcula por el método volumétrico de Simpson Modificado 65%). No hay trastornos segmentarios de la contractilidad ni gradiente obstructivo en el tracto de salida. No se observan imágenes sugestivas de trombos intracavitarios evaluados por múltiples proyecciones. El flujo Doppler mitral sugiere función diastólica no valorable. 12. VÁLVULAAÓRTICA: De apariencia trivalva, adecuada coaptación de sus velos sin insuficiencia y sin estenosis. (V. max: 1. 5 m/seg, Gradiente pico: 9mmHg, VTI TSVI: 27cm) 13. AORTA: Raíz de la aórta y aórta ascendente no lucen dilatadas, con cayado aortico normal, aórta descendente sin coartación. Sin flujo diastólico reverso en la aórta descendente.
Conclusiones:
Ventrículo izquierdo de dimensiones normales, con función sistólica preservada (FEVI 65%). Función diastólica no valorable. · Sin trastornos segmentarios de la contractilidad ni gradiente obstructivo en el tracto de salida. · Ventrículo derecho de tamaño y función normal. · Aurícula izquierda severamente dilatada, Aurícula derecha dilatada · Estenosis mitral severa de origen reumático · Probabilidad alta para hipertensión pulmonar

EXAMEN FÍSICO
Presión arterial (mmHg): 100/54, Presión arterial media(mmhg): 69
Frecuencia cardíaca(Lat/min): 106 Pulso(Pulsa/min): 106 Frecuencia respiratoria(Respi/min): 12
Saturación de oxígeno 93%, sin oxígeno
Escala del dolor: 0

Examen Físico:
Aspecto general
Aspecto general : Normal.

Diagnósticos activos después de la nota Diagnóstico principal - I519 - ENFERMEDAD CARDIACA NO ESPECIFICADA (En Estudio), Fecha

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	

NOTAS MÉDICAS

de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, R060 - DISNEA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, Z358 - SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses.

ANÁLISIS DEL CASO Y PLAN DE MANEJO

Análisis: Análisis:
Paciente de 20 años, sin antecedentes médicos relevantes, actualmente cursa con embarazo en segundo trimestre de gestación (23 semanas). Hospitalizada en contexto de palpitaciones y disminución de la clase funcional de 2 meses de evolución. Cuenta con Ecocardiograma TT que confirma estenosis mitral severa de origen reumatico asociado a dilatación auricular izquierda severa, probabilidad alta de HTP y dilatación de aurícula derecha. Pro BNP de 416.

Por parte de cardiología será discutida en junta cardio quirúrgica el 14/02/2025. Indicamos realizar ecocardiograma TE para definir Wilkins previamente y evaluar la posibilidad de angioplastia percutánea con balón. Dado el alto riesgo que tiene la intervención en el embarazo, requiere de valoración multidisciplinaria en conjunto con la decisión de la paciente. Por el momento con taquicardia sinusal, sin generar inestabilidad hemodinámica, en caso de arritmia, ante beneficio y riesgo se definirá inicio de betabloqueador.

Diagnósticos:
Estenosis mitral severa de origen reumático.
Alta probabilidad de hipertensión pulmonar.
Embarazo en segundo trimestre.

Plan de manejo: Plan:
Se solicita concepto de junta cardioquirúrgica (A realizarse el 14/02/2025).
Ecocardiograma TE

Justificación de permanencia en el servicio: Estenosis mitral severa.

Fecha: 13/02/2025 10:06 - Ubicación: ALTO RIESGO OBSTETRICO
Evolución médica - GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Condiciones del paciente: Materna
Gesta: 1

ANAMNESIS

DIAGNOSTICOS
1. G1P0
2. EMBARAZO DE 24 SEMANAS POR ECOGRAFÍA 12/11/2024 10. 5
3. DISNEA EN ESTUDIO
3. 1 ESTENOSIS MITRAL SEVERA DE ORIGEN REUMÁTICO
3. 2 ALTA PROBABILIDAD DE HIPERTENSIÓN PULMONAR
4. BACTERIURIA ASINTOMÁTICA

SUBJETIVO
PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN, NIEGA EPISODIOS DE DOLOR TORÁCICO, NIEGA DISNEA, NIEGA BENDOPNEA, NIEGA ORTOPNEA. TOLERANDO VÍA ORAL, DIURESIS Y DEPOSICIONES PRESENTES SIN ALTERACIONES. NIEGA PÉRDIDAS VAGINALES, SIN ACTIVIDAD UTERINA.

Objetivo:
OBJETIVO:
ENCUENTRO A PACIENTE EN CAMA, SIN ACOMPAÑANTE, EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA NI SIRS.

-PARACLINICOS-
13/02/2025

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	

NOTAS MÉDICAS

CALCIO: 8. 52
ANTICUERPOS TIROIDEOS PEROXIDASA: PENDIENTE (0210)
DIMERO D: 0. 93, T4L: 1. 15

12/02/2025
UROCULTIVO: PENDIENTE (0684)

EXAMEN FÍSICO--
SIGNOS VITALES: TA: 90/60 MMHG, // FC: 79 LPM, // FR: 18 RPM, // T°: 36. 1°C, // SO2: 96%
BUENAS CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, CONJUNTIVAS PÁLIDAS, ROSADAS
C/P RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS SOPLO HOLOSISTÓLICO EN FOCO MITRAL, MV CONSERVADO SIN SOBREAGREGADOS
ABDOMEN ÚTERO GRÁVIDO, AU: 22 CM, FUVCDI, MOVIMIENTOS FETALES PRESENTES, NO ACTIVIDAD UTERINA, NO DOLOR FCF: 145
G/U SIN SANGRADO, NO AMNIORREA, SE OMITE TV
LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS.
DIURESIS: 1. 9 CC/KG/HORA EN 7 HORAS

EXAMEN FÍSICO
Escala del dolor: No aplica.

Diagnósticos activos después de la nota Diagnóstico principal - I519 - ENFERMEDAD CARDIACA NO ESPECIFICADA (En Estudio), Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, R060 - DISNEA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, Z358 - SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses.

ANÁLISIS DEL CASO Y PLAN DE MANEJO

Análisis: ANÁLISIS:
PACIENTE DE 20 AÑOS G1P0 CON EMBARAZO DE 24 SEMANAS, HOSPITALIZADA EN CONTEXTO DE:

1. DISNEA EN ESTUDIO DE APROXIMADAMENTE DOS MESES DE EVOLUCIÓN, CUENTA CON ECOCARDIOGRAMA TT QUE EVIDENCIÓ ESTENOSIS MITRAL SEVERA DE ORIGEN REUMÁTICO ASOCIADO A DILATACIÓN AURICULAR IZQUIERDA SEVERA, PROBABILIDAD ALTA DE HTP Y DILATACIÓN DE AURÍCULA DERECHA CON PROBNP EN 416. YA FUE VALORADA POR CARDIOLOGÍ/ QUIENES LLEVARÁN EL CASO A JUNTA EL 14/02/25 E INDICARON TOMA DE ECO TE AÚN PENDIENTE TOMA.

2. BACTERIURIA ASINTOMÁTICA: UROANÁLISIS PATOLÓGICO SIN SÍNTOMAS URINARIOS OBSTRUCTIVOS, SE INDICÓ CEFAZOLINA 1 GRAMO CADA 6 HORAS, CON UROCULTIVO PREVIO PENDIENTE.

ACTUALMENTE PACIENTE SE ENCUENTRA CLÍNICAMENTE ESTABLE, NIEGA CEFALEA, SIN DISNEA, ORTOPNEA, NI SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, SIN EDEMA EN MIEMBROS INFERIORES, PACIENTE CON DIAGNÓSTICOS ANOTADOS SE OFRECE LA POSIBILIDAD DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO POR PATOLOGÍA MATERNA, YA FUE VALORADA POR PSICOLOGÍA, REFIERE QUE DESEA CONTINUAR CON EMBARAZO. DE MOMENTO CONTINUAREMOS A LA ESPERA DE JUNTA DE CARDIOLOGÍA PARA DEFINIR FUTURAS CONDUCTAS. SE EXPLICA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTIENDE Y ACEPTA

Plan de manejo: PLAN:
HOSPITALIZACIÓN EN ARO
DIETA COMÚN
CEFAZOLINA 1 GR EV CADA 6 HORAS (FI: 13/02/2025)
CONTROL DE SIGNOS VITALES AVISAR CAMBIOS

PENDIENTE:
ECOGRAFIA DE DETALLE ANATOMICO
ECOCARDIOGRAMA TE
JUNTA CARDIOLOGÍA 14/02/2025

NOTAS MÉDICAS

Fecha: 14/02/2025 06:52 - Ubicación: ALTO RIESGO OBSTETRICO
Evolución médica - Tratante - GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Tipo de evolución: Evolución adicional
Causa externa: ENFERMEDAD GENERAL

Condiciones del paciente: Materna
Gesta: 1

ANAMNESIS
Subjetivo: ARO EVOLUCIÓN DÍA 13/02/2025
EDAD: 20 AÑOS
CC. 1080832733

DIAGNOSTICOS
1. G1P0
2. EMBARAZO DE 24, 1 SEMANAS POR ECOGRAFÍA 12/11/2024 10. 5
3. DISNEA EN ESTUDIO
3. 1 ESTENOSIS MITRAL SEVERA DE ORIGEN REUMÁTICO
3. 2 ALTA PROBABILIDAD DE HIPERTENSIÓN PULMONAR
4. BACTERIURIA ASINTOMÁTICA

SUBJETIVO
PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN, NIEGA EPISODIOS DE DOLOR TORÁCICO, NIEGA DISNEA, NIEGA BENDOPNEA, NIEGA ORTOPNEA. TOLERANDO VÍA ORAL, DIURESIS Y DEPOSICIONES PRESENTES SIN ALTERACIONES. NIEGA PÉRDIDAS VAGINALES, SIN ACTIVIDAD UTERINA.

Objetivo: ENCUENTRO A PACIENTE EN CAMA, SIN ACOMPAÑANTE, EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA NI SIRS.

-PARACLINICOS-
14/02/2025
TIROIDEOS PEROXIDASA ANTICUERPOS < 0. 8 (NEGATIVO)
UROCULTIVO: NEGATIVO

13/02/2025
CALCIO: 8. 52
DIMERO D: 0. 93, T4L: 1. 15

11/02/2025 5:24
PEPTIDO ATRIAL NATRIURETICO: 416// TSH:4. 330//
BUN:6. 4// K:4. 21// NA:136. 2// CREA:0. 50
UROANÁLISIS: UROANALISIS: COLOR: AMARILLO, ASPECTO: CALRO, ENSIDAD: 1. 022, PH: 6, LEUCOCITOS: 25, NITRITOS, PROTEINAS, BILIRRUBINA, SANGRE: NEGATIVO, GLUICOSA:NORMAL, CUERPOS CETONICS: 10, UROBILINOGENO: 2.
SEDIMENTO URINARIO: LEU: 15. 3, ERITRO: 0. 9, CELULAS EPITELIALES: 8. 9, CILINDROS: -, BACTERIAS: +++, CRISTALES:+, MOCO: NEGATIVO (PATOLÓGICO)

2:22
PEPTIDO ATRIAL NATRIURETICO: 477//
CL:101. 8// GLU:101//K:3. 61// NA:136. 3// CREA:0. 49
HEMOGRAMA LEU:9320//NEU:63. 4%// HB:11. 1// HTO:35. 4// VCM:86. 3// PQTS:231000
GASES: pH:7. 43// PCO2:33//PO2:87//SO2:97. 7//HCO3:21. 9// BE:-2. 0

10/02/2025 ECG: FC: 65 lpm, ritmo sinusal, eje 30°, pobre progresio?n de la onda R.

Imágenes:
Ecocardiograma TT (11/02/25):
1. VENA CAVA INFERIOR: Normal, con colapso inspiratorio mayor del 50%. 2. AURÍCULA DERECHA: Dilatada, sin observarse trombos en su interior. 3. VÁLVULA TRICÚSPIDE: Con adecuada implantación y movilidad de sus velos, insuficiencia tricúspidea leve fisiológica, sin

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	

NOTAS MÉDICAS

estenosis, que permite cálculo de PSAP en 49mmHg. 4. VENTRÍCULO DERECHO: De tamaño normal, no hipertrófico, con función longitudinal preservada, sin trastornos de contractilidad. 5. VÁLVULA PULMONAR: sin insuficiencia. TAP: 94ms. 6. ARTERIA PULMONAR: Normales. 7. SÉPTUM INTERAURICULAR: Parece estar íntegro. 8. SÉPTUM INTERVENTRICULAR: Integro. 9. AURÍCULA IZQUIERDA: Severamente dilatada, sin trombos. 10. VÁLVULA MITRAL: Engrosamiento moderado de sus velos, El velo anterior presenta apertura en palo de jockey y el velo posterior esta restringido en su movimiento, condiciona una estenosis mitral severa (V. Max 2. 8m/s, GP: 32 mmHg, GM: 20 mmHg, AVM por VTI 1. 0cm2, THP 164 ms, AVM THP: 1. 3cm2). Sin insuficiencia. Aparato subvalvular con engrosamiento de las cuerdas tendinosas. 11. VENTRÍCULOIZQUIERDO: De forma y tamaño normal, con espesor normal. Los volúmenes ventriculares están preservados y la función sistólica normal (Fracción de eyección se calcula por el método volumétrico de Simpson Modificado 65%). No hay trastornos segmentarios de la contractilidad ni gradiente obstructivo en el tracto de salida. No se observan imágenes sugestivas de trombos intracavitarios evaluados por múltiples proyecciones. El flujo Doppler mitral sugiere función diastólica no valorable. 12. VÁLVULAAÓRTICA: De apariencia trivalva, adecuada coaptación de sus velos sin insuficiencia y sin estenosis. (V. max: 1. 5 m/seg, Gradiente pico: 9mmHg, VTI TSVI: 27cm) 13. AORTA: Raíz de la aórta y aórta ascendente no lucen dilatadas, con cayado aortico normal, aórta descendente sin coartación. Sin flujo diastólico reverso en la aórta descendente.
Conclusiones:
Ventrículo izquierdo de dimensiones normales, con función sistólica preservada (FEVI 65%). Función diastólica no valorable. · Sin trastornos segmentarios de la contractilidad ni gradiente obstructivo en el tracto de salida. · Ventrículo derecho de tamaño y función normal. · Aurícula izquierda severamente dilatada, Aurícula derecha dilatada · Estenosis mitral severa de origen reumático · Probabilidad alta para hipertensión pulmonar

EXAMEN FÍSICO--
SIGNOS VITALES: TA: 100/66 MMHG, // FC: 71 LPM, // FR: 18 RPM, // T°: 36°C, // SO2: 97%
BUENAS CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, CONJUNTIVAS PÁLIDAS, ROSADAS
C/P RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS SOPLO HOLOSISTÓLICO EN FOCO MITRAL, MV CONSERVADO SIN SOBREAGREGADOS
ABDOMEN ÚTERO GRÁVIDO, AU: 22 CM, FUVCDI, MOVIMIENTOS FETALES PRESENTES, NO ACTIVIDAD UTERINA, NO DOLOR FCF: 145
G/U SIN SANGRADO, NO AMNIORREA, SE OMITE TV
LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS.
DIURESIS: 0. 8 CC/KG/HORA EN 7 HORAS

EXAMEN FÍSICO
Escala del dolor: 0.

Diagnósticos activos después de la nota Diagnóstico principal - I519 - ENFERMEDAD CARDIACA NO ESPECIFICADA (En Estudio), Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, R060 - DISNEA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, Z358 - SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses.

ANÁLISIS DEL CASO Y PLAN DE MANEJO

Análisis: PACIENTE DE 20 AÑOS G1P0 CON EMBARAZO DE 24, 1 SEMANAS, HOSPITALIZADA EN CONTEXTO DE:

1. DISNEA EN ESTUDIO DE APROXIMADAMENTE DOS MESES DE EVOLUCIÓN, CUENTA CON ECOCARDIOGRAMA TT QUE EVIDENCIÓ ESTENOSIS MITRAL SEVERA DE ORIGEN REUMÁTICO ASOCIADO A DILATACIÓN AURICULAR IZQUIERDA SEVERA, PROBABILIDAD ALTA DE HTP Y DILATACIÓN DE AURÍCULA DERECHA CON PROBNP EN 416. YA FUE VALORADA POR CARDIOLOGÍA QUIENES LLEVARÁN EL CASO A JUNTA EL 14/02/25 E INDICARON TOMA DE ECO TE AÚN PENDIENTE TOMA.

2. BACTERIURIA ASINTOMÁTICA: UROANÁLISIS PATOLÓGICO SIN SÍNTOMAS URINARIOS OBSTRUCTIVOS, SE INDICÓ CEFAZOLINA 1 GRAMO CADA 6 HORAS. DADOS RESULTADOS NEGATIVOS DE UROCULTIVO SE SUSPENDE ANTIBIOTICOTERAPIA.

ACTUALMENTE PACIENTE SE ENCUENTRA CLÍNICAMENTE ESTABLE, NIEGA CEFALEA, SIN DISNEA, ORTOPNEA, NI SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, SIN EDEMA EN MIEMBROS INFERIORES, PACIENTE CON DIAGNÓSTICOS ANOTADOS SE OFRECE LA POSIBILIDAD DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO POR PATOLOGÍA MATERNA, YA FUE VALORADA POR PSICOLOGÍA, REFIERE QUE DESEA CONTINUAR CON EMBARAZO. DE MOMENTO CONTINUAREMOS A LA ESPERA DE JUNTA DE CARDIOLOGÍA PARA DEFINIR FUTURAS CONDUCTAS. SE EXPLICA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTIENDE Y ACEPTA

Plan de manejo: HOSPITALIZACIÓN EN ARO
DIETA COMÚN
SUSPENDER CEFAZOLINA 1 GR EV CADA 6 HORAS (FI: 13/02/2025)
CONTROL DE SIGNOS VITALES AVISAR CAMBIOS

PENDIENTE:
ECOGRAFIA DE DETALLE ANATOMICO
ECOCARDIOGRAMA TE

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	

NOTAS MÉDICAS

JUNTA CARDIOLOGÍA 14/02/2025

Justificación de permanencia en el servicio: PENDIENTE JUNTA MÉDICA POR CARDIOLOGÍA.

Nota aclaratoria

Fecha: 14/02/2025 09:48

Se inicia maduración pulmonar con BETAMETASONA 12 MG IM CADA 24 HRS POR 2 DOSIS

Nota aclaratoria

Fecha: 14/02/2025 10:08

Paciente será comentada en Comité. Se indica iniciar anticoagulación con Enoxaparina 60cc cada 12 horas.

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA JUNTA
Motivo de la junta médica: Definir manejo

DIAGNOSTICOS
1. G1P0
2. EMBARAZO DE 24 SEMANAS POR ECOGRAFÍA 12/11/2024 10. 5
3. DISNEA EN ESTUDIO
3. 1 ESTENOSIS MITRAL SEVERA DE ORIGEN REUMÁTICO
3. 2 ALTA PROBABILIDAD DE HIPERTENSIÓN PULMONAR
4. BACTERIURIA ASINTOMÁTICA

Ayudas diagnósticas:

Laboratorios:
11/02/2025 Leu:9320 Neu:5910 Lin:177 Eos:1210 Plt:231000 Hb:11. 1 Hto:35. 4% VCM:86. 3 HCM:27. 1 Pro BNP:477 Glu:101 K:3. 61 Na:136. 3 Cl:101. 8 TSH:4. 33 ProBNP:416 Cr:0. 5 BUN:6. 4 K:4. 21 Na:136. 2

10/02/2025 ECG: FC: 65 lpm, ritmo sinusal, eje 30°, pobre progresión de la onda R.

Ecocardiograma TT (11/02/25):

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	

NOTAS MÉDICAS

1. VENA CAVA INFERIOR: Normal, con colapso inspiratorio mayor del 50%. 2. AURÍCULA DERECHA: Dilatada, sin observarse trombos en su interior. 3. VÁLVULA TRICÚSPIDE: Con adecuada implantación y movilidad de sus velos, insuficiencia tricúspidea leve fisiológica, sin estenosis, que permite cálculo de PSAP en 49mmHg. 4. VENTRÍCULO DERECHO: De tamaño normal, no hipertrófico, con función longitudinal preservada, sin trastornos de contractilidad. 5. VÁLVULA PULMONAR: sin insuficiencia. TAP: 94ms. 6. ARTERIA PULMONAR: Normales. 7. SÉPTUM INTERAURICULAR: Parece estar íntegro. 8. SÉPTUM INTERVENTRICULAR: Integro. 9. AURÍCULA IZQUIERDA: Severamente dilatada, sin trombos. 10. VÁLVULA MITRAL: Engrosamiento moderado de sus velos, El velo anterior presenta apertura en palo de jockey y el velo posterior esta restringido en su movimiento, condiciona una estenosis mitral severa (V. Max 2. 8m/s, GP: 32 mmHg, GM: 20 mmHg, AVM por VTI 1. 0cm2, THP 164 ms, AVM THP: 1. 3cm2). Sin insuficiencia. Aparato subvalvular con engrosamiento de las cuerdas tendinosas. 11. VENTRÍCULOIZQUIERDO: De forma y tamaño normal, con espesor normal. Los volúmenes ventriculares están preservados y la función sistólica normal (Fracción de eyección se calcula por el método volumétrico de Simpson Modificado 65%). No hay trastornos segmentarios de la contractilidad ni gradiente obstructivo en el tracto de salida. No se observan imágenes sugestivas de trombos intracavitarios evaluados por múltiples proyecciones. El flujo Doppler mitral sugiere función diastólica no valorable. 12. VÁLVULAAÓRTICA: De apariencia trivalva, adecuada coaptación de sus velos sin insuficiencia y sin estenosis. (V. max: 1. 5 m/seg, Gradiente pico: 9mmHg, VTI TSVI: 27cm) 13. AORTA: Raíz de la aórta y aórta ascendente no lucen dilatadas, con cayado aórtico normal, aórta descendente sin coartación. Sin flujo diastólico reverso en la aórta descendente.

Conclusiones:
Ventrículo izquierdo de dimensiones normales, con función sistólica preservada (FEVI 65%). Función diastólica no valorable. · Sin trastornos segmentarios de la contractilidad ni gradiente obstructivo en el tracto de salida. · Ventrículo derecho de tamaño y función normal. · Aurícula izquierda severamente dilatada, Aurícula derecha dilatada · Estenosis mitral severa de origen reumático · Probabilidad alta para hipertensión pulmonar

.

Diagnósticos activos después de la nota Diagnóstico principal - I519 - ENFERMEDAD CARDIACA NO ESPECIFICADA (En Estudio), Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, R060 - DISNEA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, Z358 - SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses.

ANÁLISIS DEL CASO Y PLAN DE MANEJO
Análisis: Se analizan HC y estudios del paciente en junta donde participan los servicios de Cardiología clínica, Cardiología intervencionista, Cirugía Cardiovascular y Ginecología. Se considera :

1. Paciente G1P0 con embarazo de 23 semanas con estenosis mitral severa sintomática con alto riesgo quirúrgico. Se debe tomar decisión sobre el tipo de intervención, momento óptimo de su realización, así como momento de finalización de la gestación. Existe un alto riesgo de muerte fetal y materna por lo que incluso se considera la posibilidad de requerir protocolo de asistolia fetal en caso extremo. Dado lo anterior la decisión de plan terapéutico óptimo debe tomarse en una junta institucional conformada por: Cardiología Clínica, Cirugía cardiovascular, Ginecología, Perinatología, Terapia intensiva y Anestesiología Cardiovascular. Se plantea dicha junta a realizarse el 21/02/2025.
2. Por el momento se decide mantener embarazo hasta minimo semana 28 (intrahospitalaria) logrando vigilancia estricta y ahi evaluar la intervención a realizar.
3. Se le explica ampliamente a la paciente riesgos que puede conllevar la continuidad de la gestación.
4. Debe continuar B bloqueador con Metoprolol succinato 12. 5 mg cada día y titular según tolerancia y respuesta
5. Tiene disminución de las velocidades en auriculilla por lo que tiene indicación de anticoagulación en ritmo sinusal, por lo que se recomienda Enoxaparina 1 mg/kg cada 12 horas.
Plan de manejo: Ver analisis

Condiciones del paciente: Materna
Gesta: 1

NOTAS MÉDICAS

ANAMNESIS
Subjetivo: *** CIRUGIA CARDIOVASCULAR ***

Diagnosticos:
G1P0
Embarazo de 24 semanas por ecografia 12/11/2024 (10. 5 ss)
Estenosis mitral severa de origen reumatico
Alta probabilidad de hipertension pulmonar
Bacteriuria asintomatica
Objetivo:.

EXAMEN FÍSICO
Escala del dolor: 0.

Diagnósticos activos después de la nota Diagnóstico principal - I519 - ENFERMEDAD CARDIACA NO ESPECIFICADA (En Estudio), Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, R060 - DISNEA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, Z358 - SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses.

ANÁLISIS DEL CASO Y PLAN DE MANEJO

Análisis: Paciente joven, G1P0, con embarazo de 23 semanas, portadora de una estenosis mitral severa, con area severamente reducida y sintomas asociados a su estado gestacional.
Paciente con alto riesgo de eventos cardiovasculares mayores, por lo que debe permanecer hospitalizada.
Se discutió ampliamente el caso en junta médica cardioquirurgica, en la cual se concluyó se dará manejo intrahospitalario para continuar vigilancia estricta y llevar el feto hacia la mayor viabilidad posible hasta por lo menos 28 semanas, para evaluar nuevamente y determinar si la paciente es tributaria de realizar finalización de su proceso gestacional y posteriormente definir qué manejo se le va a ofrecer para su estenosis aortica.
Se realizará evaluación del caso en conjunto con perinatologia, neonatologia, anestesiología cardiovascular para estar atentos de cualquier situacion que pueda presentarse y dar una respuesta oportuna por parte de cirugia cardiovascular y cardiologia clínica. Continuamos atentos al caso.

Plan de manejo:.

Justificación de permanencia en el servicio:.

Fecha: 14/02/2025 19:42 - Ubicación: ALTO RIESGO OBSTETRICO
Evolución médica - GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Condiciones del paciente: Materna
Gesta: 1

ANAMNESIS
Subjetivo:

DIAGNOSTICOS DE MANEJO:
1. G1P0
2. EMBARAZO DE 24, 1 SEMANAS POR ECOGRAFÍA 12/11/2024 10. 5
3. DISNEA EN ESTUDIO
--- ESTENOSIS MITRAL SEVERA DE ORIGEN REUMÁTICO
--- ALTA PROBABILIDAD DE HIPERTENSIÓN PULMONAR
4. BACTERIURIA ASINTOMÁTICA

SUBJETIVO
PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN, NIEGA EPISODIOS DE DOLOR TORÁCICO, NIEGA DISNEA, NIEGA BENDOPNEA, NIEGA ORTOPNEA. TOLERANDO VÍA ORAL, DIURESIS Y DEPOSICIONES PRESENTES SIN ALTERACIONES. NIEGA PÉRDIDAS VAGINALES,

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	

NOTAS MÉDICAS

SIN ACTIVIDAD UTERINA
Objetivo:.

EXAMEN FÍSICO
Escala del dolor: 0

Examen Físico:
Aspecto general
Aspecto general : SIGNOS VITALES: TA: 105/68 MMHG, // FC: 67 LPM, // FR: 18 RPM, // T°: 36°C, // SO2: 97%
BUENAS CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, CONJUNTIVAS PÁLIDAS, ROSADAS
C/P RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS SOPLO HOLOSISTÓLICO EN FOCO MITRAL, MV CONSERVADO SIN SOBREAGREGADOS
ABDOMEN ÚTERO GRÁVIDO, AU: 22 CM, FUVCDI, MOVIMIENTOS FETALES PRESENTES, NO ACTIVIDAD UTERINA, NO DOLOR
G/U SIN SANGRADO, NO AMNIORREA, SE OMITE TV
LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS.

Diagnósticos activos después de la nota Diagnóstico principal - I519 - ENFERMEDAD CARDIACA NO ESPECIFICADA (En Estudio), Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, R060 - DISNEA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, Z358 - SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses.

ANÁLISIS DEL CASO Y PLAN DE MANEJO

Análisis: PACIENTE DE 20 AÑOS G1P0 CON EMBARAZO DE 24, 1 SEMANAS, HOSPITALIZADA EN CONTEXTO DE:

1. DISNEA EN ESTUDIO DE APROXIMADAMENTE DOS MESES DE EVOLUCIÓN, CUENTA CON ECOCARDIOGRAMA TT QUE EVIDENCIÓ ESTENOSIS MITRAL SEVERA DE ORIGEN REUMÁTICO ASOCIADO A DILATACIÓN AURICULAR IZQUIERDA SEVERA, PROBABILIDAD ALTA DE HTP Y DILATACIÓN DE AURÍCULA DERECHA CON PROBNP EN 416. YA FUE VALORADA POR CARDIOLOGÍ/ QUIENES LLEVARÁN EL CASO A JUNTA EL 14/02/25. INDICARÓN INICIAR MANEJO CON METOPROLOL + ANTICPOAGULACIÓN PLENA.

2. BACTERIURIA ASINTOMÁTICA: UROANÁLISIS PATOLÓGICO SIN SÍNTOMAS URINARIOS OBSTRUCTIVOS, SE INDICÓ CEFAZOLINA 1 GRAMO CADA 6 HORAS. DADOS RESULTADOS NEGATIVOS DE UROCULTIVO SE SUSPENDE ANTIBIOTICOTERAPIA.

PACIENTE CON DIAGNÓSTICOS ANOTADOS SE OFRECE LA POSIBILIDAD DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO POR PATOLOGÍA MATERNA, YA FUE VALORADA POR PSICOLOGÍA, REFIERE QUE DESEA CONTINUAR CON EMBARAZO, CONA LTO RIEGSO DE MORBIMORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL.

EN EL MOMENTO ESTABILIDAD CLINICA Y HEMDOINAMICA, NIECGA CEFALEA, DISNEA O DOLRO TORACICO, NIEGA PERDIDAS VAGINALES. INDICA NO DISMINUCIÓN DE SU CLASE FUNCIONAL.
SERA COMENTADA EN JUNTA DE GINECOLOGIA EL MARTES.
SE EXPLICA A PACIENTE QUIEN DICE ENTENDER Y ACEPTAR

Plan de manejo: HOSPITALIZAR EN ARO 1
DIETA CORRIENTE
TAPÓN SALINO
METOPROLOL TAB 12. 5 MG, DAR 1 TAB VO AL DIA
ENOXAPARINA AMP 60 MG, APLICAR 1 AMP SC CADA 12 HORAS
PTE JUNTA DE CARDIOLOGIA - GINECOLOGIA
CONTROL DE SIGNOS VITALKES - FCF
GRACIAS :)

Justificación de permanencia en el servicio:.

--REGISTRO PENDIENTE DE AVAL--

Fecha: 15/02/2025 09:30 - Ubicación: ALTO RIESGO OBSTETRICO
Evolución médica - GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Condiciones del paciente: Materna

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	

NOTAS MÉDICAS

Gesta: 1

ANAMNESIS
Subjetivo: diagnostico
-G1
-Embarazo de 24 ss por eco
-Disena en estudio
--Estenosis mitral severa
--Alto riesgo de hipertension pulmonar

subjetivo
refiere pasar buena noche sin dolor niega angor o disnea tolerando via oral sin sintomas premonitorios afirma movimientos fetales sin actividad uterina diuresis presente
Objetivo: FC 87 lpm FR 18 rpm TA 95/59 mmHg Sat 98%

normocefalo pupilas isocoricas normocromicas escleras anictericas mucosa oral humeda cuello movil simetrico
torax simetrico expansible murmullo vesicular presente bibabal sin agregados ruidos cardiacos ritmicos R1 reforzado con soplo mesodiastolico foco mitral
abdomen globoso por utero gravido fcf 129 lpm sin signos de irritacion peritoneal
genitales normoconfigurados tv se omite
extremidades simetricas eutroficas llenado inmediatos
snc sin focalizaciones motoras o sensitivas aparentes

EXAMEN FÍSICO
Escala del dolor: No aplica

Diagnósticos activos después de la nota Diagnóstico principal - I519 - ENFERMEDAD CARDIACA NO ESPECIFICADA (En Estudio), Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, R060 - DISNEA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, Z358 - SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses.

ANÁLISIS DEL CASO Y PLAN DE MANEJO

Análisis: Paciente de 20 años G1 actualmente con embarazo de 24 ss en estancia en ARO I en el contexto:

-disnea: paciente con reporte de eccoardiograma con engrosamiento moderado de sus velos con el velo anterior presenta apertura en palo de jockey y el velo posterior esta restringido en su movimiento, condiciona una estenosis mitral severa (V. Max 2. 8m/s, GP: 32 mmHg, GM: 20 mmHg, AVM por VTI 1. 0cm2, THP 164 ms, AVM THP: 1. 3cm2) de origen reumatico valorada en junta cardioquirurgica que indica manejo expectante hasta 28 ss y manejo anticoagulante por bajas velocidades en auriculilla y betabloqueador se realizo un ecocardiograma transesofagico cuyo reporte esta pendiente. Pendiente presentar en comite maternofetal. Enfermeria comenta que betabloqueador no esta siendo administrado porque no esta disponible, pendiente gestionar.

actualmente alerta afebril tolerando via oral sin cambios en la semiologia abdominal con adecuado patron respirato hemodinamicamente estable sin sintomas premonitorios afirma movimientos fetales sin actividad uterina. se indica continuar manejo medico instaurado, alto riesgo obstetrico, entiende y acepta

Plan de manejo: plan
-estancia en ARO
-dieta normal
-tapon heparinizado
-control de signos vitales
-avisar cambios

medicamentos
-enoxaparina 60 mg sc cada 12 horas
-metoprolol 12. 5 mg vo cada 12 horas

Imagenes
-pendiente reporte de ecocardiograma tranesofagico

Interconsultas
-seguimiento por cardiologia y ciruiga cardiovascular

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	

NOTAS MÉDICAS

R2:

Justificación de permanencia en el servicio:.

Nota aclaratoria

Fecha: 15/02/2025 09:31

Metoprolol succinato 12.5 mg vo cada 24 horas

Fecha: 16/02/2025 09:19 - Ubicación: ALTO RIESGO OBSTETRICO
Evolución médica - GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Condiciones del paciente: Materna
Gesta: 1

ANAMNESIS
Subjetivo:.
Objetivo:.

EXAMEN FÍSICO
Escala del dolor: No aplica.

Diagnósticos activos después de la nota Diagnóstico principal - I519 - ENFERMEDAD CARDIACA NO ESPECIFICADA (En Estudio), Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, R060 - DISNEA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, Z358 - SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses.

ANÁLISIS DEL CASO Y PLAN DE MANEJO

Análisis: diagnostico
-G1
-Embarazo de 24. 1 ss por eco
-Disena en estudio
--Estenosis mitral severa
--Alto riesgo de hipertension pulmonar

subjetivo
refiere pasar buena noche sin dolor niega angor o disnea tolerando via oral sin sintomas premonitorios afirma movimientos fetales sin actividad uterina diuresis presente

Objetivo:
FC 80 lpm FR 18 rpm TA 104/55 mmHg Sat 98%

normocefalo pupilas isocoricas normocromicas escleras anictericas mucosa oral humeda cuello movil simetrico
torax simetrico expansible murmullo vesicular presente bibabal sin agregados ruidos cardiacos ritmicos R1 reforzado con soplo mesodiastolico foco mitral
abdomen globoso por utero gravido fcf 151 lpm sin signos de irritacion peritoneal
genitales normoconfigurados tv se omite
extremidades simetricas eutroficas llenado inmediatos
snc sin focalizaciones motoras o sensitivas aparentes

Análisis: Paciente de 20 años G1 actualmente con embarazo de 24. 1 ss en estancia en ARO I en el contexto:

-disnea: paciente con reporte de eccoardiograma con engrosamiento moderado de sus velos con el velo anterior presenta apertura en palo de jockey y el velo posterior esta restringido en su movimiento, condiciona una estenosis mitral severa (V. Max 2. 8m/s, GP: 32 mmHg, GM: 20 mmHg, AVM por VTI 1. 0cm2, THP 164 ms, AVM THP: 1. 3cm2) de origen reumatico valorada en junta cardioquirurgica que indica manejo

NOTAS MÉDICAS

expectante hasta 28 ss y manejo anticoagulante por bajas velocidades en auriculilla y betabloqueador se realizo un ecocardiograma transesofagico cuyo reporte esta pendiente. Pendiente presentar en comite maternofetal. Enfermeria comenta que betabloqueador no esta siendo administrado porque no esta disponible, pendiente gestionar.

actualmente alerta afebril tolerando via oral sin cambios en la semiologia abdominal con adecuado patron respirato hemodinamicamente estable sin sintomas premonitorios afirma movimientos fetales sin actividad uterina. se indica continuar manejo medico instaurado, alto riesgo obstetrico, entiende y acepta

Plan de manejo:
-estancia en ARO
-dieta normal
-tapon heparinizado
-control de signos vitales
-avisar cambios

medicamentos
-enoxaparina 60 mg sc cada 12 horas
-metoprolol succinato 12. 5 mg vo cada 24 horas

Imagenes
-pendiente reporte de ecocardiograma tranesofagico

Interconsultas
-seguimiento por cardiologia y ciruiga cardiovascular

Comentado Dr Julian Delgado

Plan de manejo:. -

Justificación de permanencia en el servicio:.

Fecha: 17/02/2025 06:28 - Ubicación: ALTO RIESGO OBSTETRICO
Evolución médica - GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Condiciones del paciente: Materna
Gesta: 1

ANAMNESIS

DIAGNÓSTICOS
1. G1P0
2. EMBARAZO DE 24, 4 SEMANAS POR ECOGRAFÍA 12/11/2024 10. 5
3. DISNEA EN ESTUDIO
3. 1 ESTENOSIS MITRAL SEVERA DE ORIGEN REUMÁTICO
3. 2 ALTA PROBABILIDAD DE HIPERTENSIÓN PULMONAR

SUBJETIVO
PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN, NIEGA EPISODIOS DE DOLOR TORÁCICO, NIEGA DISNEA, NIEGA BENDOPNEA, NIEGA ORTOPNEA. TOLERANDO VÍA ORAL, DIURESIS Y DEPOSICIONES PRESENTES SIN ALTERACIONES. NIEGA PÉRDIDAS VAGINALES, SIN ACTIVIDAD UTERINA.

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	

NOTAS MÉDICAS

Objetivo:
OBJETIVO
ENCUENTRO A PACIENTE EN CAMA, SIN ACOMPAÑANTE, EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA NI SIRS.

EXAMEN FÍSICO--
SIGNOS VITALES: TA: 110/60 MMHG, // FC: 85 LPM, // FR: 19 RPM, // T°: 36. 1°C, // SO2: 98%
BUENAS CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, CONJUNTIVAS PÁLIDAS, ROSADAS
C/P RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS SOPLO HOLOSISTÓLICO EN FOCO MITRAL, MV CONSERVADO SIN SOBREAGREGADOS
ABDOMEN ÚTERO GRÁVIDO, AU: 22 CM, FUVCDI, MOVIMIENTOS FETALES PRESENTES, NO ACTIVIDAD UTERINA, NO DOLOR FCF: 145
G/U SIN SANGRADO, NO AMNIORREA, SE OMITE TV
LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS.
DIURESIS: 0. 75 CC/KG/HORA EN 5 HORAS

EXAMEN FÍSICO
Escala del dolor: No aplica.

Diagnósticos activos después de la nota Diagnóstico principal - I519 - ENFERMEDAD CARDIACA NO ESPECIFICADA (En Estudio), Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, R060 - DISNEA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, Z358 - SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses.

ANÁLISIS DEL CASO Y PLAN DE MANEJO

Análisis: ANÁLISIS:
PACIENTE DE 20 AÑOS G1P0 CON EMBARAZO DE 24, 1 SEMANAS, HOSPITALIZADA EN CONTEXTO DE:

1. DISNEA EN ESTUDIO DE APROXIMADAMENTE DOS MESES DE EVOLUCIÓN, CUENTA CON ECOCARDIOGRAMA TT QUE EVIDENCIÓ ESTENOSIS MITRAL SEVERA DE ORIGEN REUMÁTICO ASOCIADO A DILATACIÓN AURICULAR IZQUIERDA SEVERA, PROBABILIDAD ALTA DE HTP Y DILATACIÓN DE AURÍCULA DERECHA CON PROBNP EN 416. FUE LLEVADA A JUNTA CARDIOQUIRURGICA QUIENES INDICARON MANEJO EXPECTANTE HASTA LAS 28 SS, MANEJO ANTICOAGULANTE Y BETABLOQUEADOR, SIN EMBARGO POR DESABASTECIMIENTO NO SE ESTÁ ADMINISTRANDO BB. AÚN PENDIENTE REPORTE DE ECO TE. SE INDICA NUEVA VALORACIÓN POR CARDIOLOGÍA PARA EVALUAR CAMBIO DE BETABLOQUEADOR.

2. BACTERIURIA ASINTOMÁTICA: UROANÁLISIS PATOLÓGICO SIN SÍNTOMAS URINARIOS OBSTRUCTIVOS, SE INDICÓ CEFAZOLINA 1 GRAMO CADA 6 HORAS. DADOS RESULTADOS NEGATIVOS DE UROCULTIVO SE SUSPENDE ANTIBIOTICOTERAPIA.

ACTUALMENTE PACIENTE SE ENCUENTRA ESTABLE, SIN CEFALEA, DISNEA, ORTOPNEA O SIGNOS DE BAJO GASTO, DADOS DIAGNÓSTICOS DESCRITOS SE OFRECIÓ POSIBILIDAD DE IVE POR PATOLOGÍA MATERNA, YA VALORADA POR PSICOLOGÍA, REFIERE QUE DESEA CONTINUAR CON EMBARAZO. PACIENTE SERÁ COMENTADA EL DÍA 18/02/2025 EN COMITÉ MATERNO-FETAL PARA DEFINIR CONDUCTAS. Y EL 21/02/2025 EN JUNTA MULTIDISCIPLINARIA. POR EL MOMENTO CONTINUA CON IGUAL MANEJO.

Plan de manejo: PLAN:
HOSPITALIZACIÓN EN ARO
DIETA COMÚN
TAPÓN HEPARINIZADO
ENOXAPARINA AMP 60 MG UNA AMP SC CADA 12H
METOPROLOL SUCCINATO 12. 5 MG VO CADA 12 HORAS
CONTROL DE SIGNOS VITALES
AVISAR CAMBIOS

SE SOLICITA
VALORACION POR CARDIOLOGIA

PENDIENTE:
REPORTE ECOCARDIOGRAMA TE
JUNTA MATERNO-FETAL 18/02/2025

+REALIZADO:
+REVISADO POR:
- RESIDENTE GINECOLOGÍA +COMENTADO CON: GYO DE TURNO

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	

NOTAS MÉDICAS

Justificación de permanencia en el servicio:.

Nota aclaratoria

Fecha: 17/02/2025 18:29

PACIENTE DE 20 AÑOS PRIMIGESTANTE, EMBARAZO DE 24.1 SEMANAS, EN EL MOMENTO CON DIAGNOSTICO DE ESTENOSIS MITRAL SEVERA DE ORIGEN REUMATICO, ALTO RIESGO CARDIOVASCULAR, SEGUN CLASIFICACION DE WHO IV EN QUIEN NO SE RECOMIENDA EMBARAZO, POR ALTO RIESGO DE COLAPSO Y MORBI MORTALIDAD MATERNA, EL DIA DE HOY SE EXPLICA CLARAMENTE A LA PACIENTE SU DIAGNOSTICO Y EL ALTO RIESGO OBSTETRICO QUE ESTE CONLLEVA, YA SE HABIA DADO ASESORIA EN DERECHOS REPORDUCTIVOS E INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO SIN EMBARGO LA PACIENTE SE NIEGA A ESTE. HOY SE EXPLICA EL CONCEPTO DE JUNTA CARDIOQUIRURGICA DE TRATAR DE PROLONGAR EL EMBARAZO HASTA EDAD GESTACIONAL DE 28 SEMANAS PARA MEJOR PRONOSTICO FETAL SIEMPRE Y CUANDO EL ESTADO HEMODINAMICO DE LA PACIENTE LO AMERITE.
SE EXPLICA A LA PACIENTE DE IGUAL MANERA RIESGOS MATERNOS DE PROLONGACION DE LA GESTACION INCLUIDOS EL COLAPSO Y MUERTE. Y RIESGOS PERINATALES Y COMPLICACIONES ASOCIADAS A PREMATUREZ INCLUIDA MUERTE NEONATAL TEMPRANA. PACIENTE ENTIENDE Y ACEPTA.
EN EL MOMETNO POR INDICACION DE CARDIOLOGIA DEBE MANTENER FRECUENCIAS CARDIACAS AL REDEDOR DE 70LPM, INDICACION DE BETABLOQUEADOR SIN EMBARGO NO SE HA ADINISTRADO POR NO DISPONIBILIDAD EN EL SERVICO. POR EL MOMENTO POR ALTO RIESGO DE COMPLICACIONES, DEBE CONTINUAR HOSPITALIZADA.
EN EL MOMENTO NO SE CUENTA CON FAMILIAR, SE HABLA CON LA MADRE DE LA PACEINTE VIA TELEFONICA Y SE LE EXPLICA ESTADO DE LA PACIENTE Y CONDUCTA A SEGUIR, REFIERE PODRÁ VIAJAR Y ASISTIR PRESENCIALMENTE EL DIA DE MAÑANA.
TIENE PENDIENTE NUEVA JUNTA CARDIOQUIRURGICA DIA VIERNES PARA EVALUAR PLAN QUIRURGICO.

Fecha: 17/02/2025 14:02 - Ubicación: UCI CARDIOVASCULAR
Evolución médica - GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Condiciones del paciente: Materna
Gesta: 1

ANAMNESIS
Subjetivo: ********** NOTA DE EVOLUCION ADICIONAL **********
Objetivo: ENCUENTRO PACIENTE EN CAMA, ALERTA, AFEBIRL, CON TAQUIPNEA,
TA: 104/69 MMHG, // FC: 120 LPM, // FR: 33 RPM, // T°: 36°C, // SO2: 99%

C/P RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS, TAQUICARDICOS, SOPLO HOLOSISTÓLICO EN FOCO MITRAL, MV CONSERVADO SIN SOBREAGREGADOS, CAMPOS PULMONARES BIEN VENTILADOS INGURGITACION YUGULAR, UTILIZACION DE MUSCULOS ACCESORIOS.

ABDOMEN ÚTERO GRÁVIDO, NO ACTIVIDAD UTERINA, NO DOLOR FCF: 148
G/U SIN SANGRADO, NO AMNIORREA, NO SE REALIZA TV
LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS
SNC ALERTA, ORIENTADA, SIN DEFICIT.

EXAMEN FÍSICO
Escala del dolor: 0.

Diagnósticos activos después de la nota Diagnóstico principal - I519 - ENFERMEDAD CARDIACA NO ESPECIFICADA (En Estudio), Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, R060 - DISNEA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, Z358 - SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses.

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	

NOTAS MÉDICAS

ANÁLISIS DEL CASO Y PLAN DE MANEJO

Análisis: SE ATIENDE LLAMADO DE ENFERMERIA PACIENTE REFIRIENDO DIFICULTAD RESPIRATORIA Y DISNEA.

SE EVALUA PACIENTE, EN EL MOMENTO TAQUICARDICA 120LPM, CON ESFUERZO RESPIRATORIO, DISNEA DE PEQUEÑOS ESFUERZOS, FRECUENCIA RESPIRTORIA DE 33RPM. SATURANDO ADECUADAMENTE 99%. SE TOMA EKG TAQUICARDIA SINUSAL, PACIENTE CON ALTO RIESGO DE COLAPSO CARDIOVASCULAR Y DETERIORO HEMODINAMICO POR LO QUE REQUIERE VIGILANCIA ESTRICTA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS.
COMENTAMOS PACIENTE EN UCI QUIENES REFIEREN ES ACEPTADA. POR EL MOMENTO MIENTRAS SE ESPERA TRASLADO SE DEBE REALIZAR VIGILANCIA ESTRICTA EN SALA DE PARTOS.
SE EXPLICA A LA PACIENTE CONDUCTA ENTIENDE Y ACEPTA.

Plan de manejo: SE SOLICITA EKG (YA SE TOMO)
SE SOLICITA VALROACION POR UCI
TRASLADO A SALA DE PARTOS POR EL MOMENTO

Justificación de permanencia en el servicio:.

Fecha: 17/02/2025 15:00 - Ubicación: ALTO RIESGO OBSTETRICO
Evolución médica - GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Condiciones del paciente: Materna
Gesta: 1

ANAMNESIS

DIAGNÓSTICOS
1. G1P0
2. EMBARAZO DE 24, 4 SEMANAS POR ECOGRAFÍA 12/11/2024 10. 5
3. DISNEA EN ESTUDIO
 3. 1. ESTENOSIS MITRAL SEVERA DE ORIGEN REUMÁTICO
 3. 2. ALTA PROBABILIDAD DE HIPERTENSIÓN PULMONAR

ENFERMEDAD ACTUAL:
PACIENTE DE 20 AÑOS G1P0 CON EMBARAZO DE 24, 1 SEMANAS, INGRESÓ EL 10/02/2025 REMITIDA POR HISTORIA DE 2 MESES DE DISNEA PROGRESIVA A PEQUEÑOS ESFUERZOS, DOCUMENTANDOSE INSTITUCIONALMENTE ESTENOSIS MITRAL SEVERA DE ORIGEN REUMATICO CON ECO TE 14/02/2025 CON ENFERMEDAD REUMÁTICA DE LA VÁLVULA MITRAL, CON ESTENOSIS DE GRADO SEVERO E INSUFICIENCIA DE GRADO LEVE, DILATACIÓN SEVERA DE LA AURÍCULA IZQUIERDA. Y ALTA PROBABILIDAD DE HIPERTENSIÓN PULMONAR CON PROBNP DE 416.
VALORADA POR JUNTA CARDIOQUIRURGICA CON INDICACIÓN DE MANEJO INTRAHOSPITALARIO EXPECTANTE HASTA LAS 28 SS, CON INDICACION DE MANEJO FARMACOLOGICO CON BETABLOQUEADOR Y MANEJO ANTICOAGULANTE DADO DISMINUCIÓN DE LAS VELOCIDADES EN AURICULILLA, SIN EMBARGO POR DESABASTECIMIENTO NO SE ESTÁ ADMINISTRANDO BB.
ADICIONALMENTE SE LLEVARÁ A JUNTA INSTITUCIONAL EL DIA 18/02/2025 PARA DECIDIR PLAN TEURAPEUTICO OPTIMO.

PRESENTA BACTERIURIA ASINTOMÁTICA POR UROANALISIS INSTITUCIONAL POR LO QUE RECIBIÓ DE FORMA PROFILACTICA CEFAZOLINA, AHORA CUENTA CON UROCULTIVO NEGATIVO POR LO QUE SUSPENDIERON ANTIBIOTICOTERAPIA

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	

NOTAS MÉDICAS

DADOS DIAGNÓSTICOS DESCRITOS SE OFRECIÓ POSIBILIDAD DE IVE POR PATOLOGÍA MATERNA, YA VALORADA POR PSICOLOGÍA, REFIERE QUE DESEA CONTINUAR CON EMBARAZO. SERÁ COMENTADA EL 18/02/2025 EN COMITÉ MATERNO-FETAL PARA DEFINIR CONDUCTAS. Y EL 21/02/2025 EN JUNTA MULTIDISCIPLINARIA.

ADICIONALMENTE RECIBIÓ MADURACION PULMONAR CON BETAMETASONA #1 DOSIS EL 14 Y #2 DOSIS EL 15 DE FEBRERO.

EMBARAZO ACTUAL: HA REALIZADO 6 CPN, INICIO A LAS 10. 5 SS, PESO INICIAL52 KG, PESO ACTUAL: 53KG, GANANCIA DE 1 KG, CIFRAS TENSIONALES NORMALES EN CONTROLES, VALORADA POR PSICOLOGIA, TRABAJO SOCIAL, NUTRICIÓN Y ODONTOLOGIA. VACUNACION PENDIENTE TDAP, COVID. YA CUENTA CON VACUNA PARA INFLUENZA ESTACIONAL.

Objetivo: ANTECEDENTES.
-PATOLÓGICOS: ANEMIA GESTACIONAL.
-FARMACOLÓGICOS: NIEGA
-ALERGICOS: NIEGA
-QUIRÚRGICOS: NIEGA
-TÓXICOS: NIEGA
-FAMILIARES: MADRE Y HERMANAS DIABETES
G/O: G1P0, FUM NO RECUERDA, CICLOS IRREGULARES, MENARCA 15 AÑOS. CITOLOGIA 20/11/24 NEGATIVA

EXAMEN FÍSICO--
SIGNOS VITALES: TA: 106/69 MMHG, // FC: 81 LPM, // FR: 17 RPM, // T°: 36°C, // SO2: 97%
BUENAS CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, CONJUNTIVAS PÁLIDAS, ROSADAS
C/P RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS SOPLO HOLOSISTÓLICO EN FOCO MITRAL, MV CONSERVADO SIN SOBREAGREGADOS
ABDOMEN ÚTERO GRÁVIDO, AU: 22 CM, FUVCDI, MOVIMIENTOS FETALES PRESENTES, NO ACTIVIDAD UTERINA, NO DOLOR FCF: 145
G/U SIN SANGRADO, NO AMNIORREA, SE OMITE TV
LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS.
DIURESIS ESPONTÁNEA NO CUANTIFICADA

PARACLINICOS
INTRAINSTITUCIONALES
10/02/25: TSH 2. 23, T4L: 1. 28, HB: 11. 3
11/02/2025
HEMOGRAMA LEU 9. 320 N 63% HB 11. 1 HTO 35 PLT 231. 000
CREATININA 0. 5 BUN 6. 4
UROANALISIS CONTAMINADO
TSH 433
PROBNP 477
CL 101. 8 K 3. 61 NA 136. 2.

PEPTIDO ATRIAL NATRIURETICO: 416// TSH:4. 330//
BUN:6. 4// K:4. 21// NA:136. 2// CREA:0. 50
PEPTIDO ATRIAL NATRIURETICO: 477//
CL:101. 8// GLU:101//K:3. 61// NA:136. 3// CREA:0. 49
HEMOGRAMA LEU:9320//NEU:63. 4%// HB:11. 1// HTO:35. 4// VCM:86. 3// PQTS:231000
GASES: pH:7. 43// PCO2:33//PO2:87//SO2:97. 7//HCO3:21. 9// BE:-2. 0

13/02/2025 UROCULTIVO NEGATIVO

.
EXTRAINSTITUCIONALES
19/11/24: HB: 14. 2, PLAQ: 223000, O+, CICLAJE NEGATIVO, AGSHB NEG, TOXO IGM NEGATIVO, IGG POSITIVO, RUBEOLA IGM NEGATIVO, IGGPOSITIVO, FV VAGINOSIS (TRATADO METRONIDAZOL), GLUCOSA 95
13/12/24: GLUCOSA PRE 96, POST 68, HBA1C: 4. 75%
14/01/25: VIH Y SEROLOGIA NEGATIVOS.
20/01/25: HB: 10. 6, HTO: 36, PLAQ: 210000

IMAGENES:

ECOGRAFIAS
22/01/25: 20. 6 SS, PFE: 316 GR, P. - 25-50, CEFALICO, PLACENTA POSTERIOR Y FUNDICA, ILA 14
-25/11/24: 12. 2 SS, SN 0. 9, HN PRESENTE
-12/11/24: 10. 5 SS

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	

NOTAS MÉDICAS

21/02/2025
ECO TE
CONCLUSIONES:
1. Ventrículo izquierdo de dimensiones normales, con función sistólica preservada FEVI: 60%
2. Función diastólica no valorable.
3. Ventrículo derecho de dimensiones y función normal.
4. Enfermedad reumática de la válvula mitral, con estenosis de grado severo e insuficiencia de grado leve
5. Orejuela izquierda libre de trombos, con velocidades de vaciamiento reducidas.
6. Drenaje pulmonar venoso normal.
7. Dilatación severa de la aurícula izquierda.
8. No se registran cortocircuitos.
9. Probabilidad alta de hipertensión pulmonar.

EXAMEN FÍSICO
Escala del dolor: No aplica.

Diagnósticos activos después de la nota Diagnóstico principal - I519 - ENFERMEDAD CARDIACA NO ESPECIFICADA (En Estudio), Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, R060 - DISNEA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, Z358 - SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses.

ANÁLISIS DEL CASO Y PLAN DE MANEJO

Análisis: PACIENTE DE 20 AÑOS G1P0 CON EMBARAZO DE 24, 1 SEMANAS, HOSPITALIZADA EN CONTEXTO DE:

1. ESTENOSIS MITRAL SEVERA DE ORIGEN REUMATICA: HISTORIA DE DISMINUCION DE LA CLASE FUNCIONAL, CON ECO TE 14/02/2025 CON ENFERMEDAD REUMÁTICA DE LA VÁLVULA MITRAL, CON ESTENOSIS DE GRADO SEVERO E INSUFICIENCIA DE GRADO LEVE, DILATACIÓN SEVERA DE LA AURÍCULA IZQUIERDA. Y ALTA PROBABILIDAD DE HIPERTENSIÓN PULMONAR CON PROBNP DE 416.
VALORADA POR JUNTA CARDIOQUIRURGICA CON INDICACIÓN DE MANEJO INTRAHOSPITALARIO EXPECTANTE HASTA LAS 28 SS, CON INDICACION DE MANEJO FARMACOLOGICO CON BETABLOQUEADOR Y MANEJO ANTICOAGULANTE DADO DISMINUCIÓN DE LAS VELOCIDADES EN AURICULILLA, SIN EMBARGO POR DESABASTECIMIENTO NO SE ESTÁ ADMINISTRANDO BB. ESTA PENDIENTE NUEVA VALORACIÓN POR CARDIOLOGÍA PARA EVALUAR CAMBIO DE BETABLOQUEADOR POR DESABASTECIMIENTO. SE LLEVARÁ A JUNTA MATERNOFETAL EL DIA 18/02/2025 Y EL 21/02/2025 A JUNTA INSTITUCIONAL PARA DECIDIR PLAN TEURAPEUTICO OPTIMO.

ACTUALMENTE PACIENTE SE ENCUENTRA ESTABLE, SIN CEFALEA, DISNEA, ORTOPNEA O SIGNOS DE BAJO GASTO, YA VALORADA POR PSICOLOGÍA, REFIERE QUE DESEA CONTINUAR CON EMBARAZO. DADO ALTO RIESGO OBSTETRICO Y RIESGO DE INESTABILIDAD HEMODINAMICA TIENE INDICACION DE SER HOSPITALIZADA EN UCI PARA VIGILANCIA ESTRICTA. POR EL MOMENTO TIENE PENDIENTE TRASLADO, SE CONTINÚA IGUAL MANEJO EN SALA DE PARTOS DADA NO DISPONIBILIDAD DE CUPO AL MOMENTO PARA UCI, A LA ESPERA DE VALORACION POR CARDIOLOGIA. SE EXPLICA A PACIENTE REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Plan de manejo: HOSPITALIZACIÓN EN SALA DE PARTOS
TRASLADO A UCI
DIETA COMÚN
TAPÓN HEPARINIZADO
ENOXAPARINA AMP 60 MG UNA AMP SC CADA 12H
METOPROLOL SUCCINATO 12. 5 MG VO CADA 12 HORAS
CONTROL DE SIGNOS VITALES
AVISAR CAMBIOS

PENDIENTE:
VALORACION POR CARDIOLOGIA
JUNTA MATERNO-FETAL 18/02/2025
JUNTA INSTITUCIONAL 21/02/2025

Justificación de permanencia en el servicio: ALTO RIESGO DE INESTABILIDAD HEMODINAMICA Y LO QUE CONLLEVA.

--REGISTRO PENDIENTE DE AVAL--

NOTAS MÉDICAS

Fecha: 17/02/2025 15:25 - Ubicación: ALTO RIESGO OBSTETRICO
Evolución médica - CIRUGIA CARDIOVAS

Condiciones del paciente: Materna
Gesta: 1

ANAMNESIS
Subjetivo: *-*-*-*
Objetivo: *-*-*-*

EXAMEN FÍSICO
Escala del dolor: No aplica

Diagnósticos activos después de la nota Diagnóstico principal - I519 - ENFERMEDAD CARDIACA NO ESPECIFICADA (En Estudio), Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, R060 - DISNEA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, Z358 - SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses.

ANÁLISIS DEL CASO Y PLAN DE MANEJO

Análisis: UCI

Paciente con D G12 P0 Emb 24 Sm cursando con Taquicardia - Disnea en el contexto de Estenosis Mitral Severa, Hipertensión Pulmnar en estudio, solicitan cupo en UCI, se acepta en UCI Cardiovascular

Al momento en espera de traslado de cuerpo a sala de paz, limpieza + desinfección de cubículo, favor coordinar traslado entre jefes de enfermería - comentar caso clínico entre Médicos tratantes - Gracias -

Plan de manejo: Aceptada en UCI Cardiovascular

Justificación de permanencia en el servicio: Emb 24 Sm / Estenosis Mitral

---

Fecha: 17/02/2025 18:09 - Ubicación: ALTO RIESGO OBSTETRICO
Ingreso a hospitalización - MEDICO INTENSIVISTA
Paciente de 20 Años y 9 meses, Género Femenino, 6 día(s) en hospitalización

Clasificación del triage: TRIAGE III Causa externa: ENFERMEDAD GENERAL

Condiciones del paciente: Materna

ANAMNESIS
Motivo de consulta: "Se ahoga"
Enfermedad actual: Paciente de 20 años con embarazo de 24 semanas quien ingresó remitida de consulta externa en contexto de palpitaciones, disnea y taquipnea de dos meses de evolución. Cuenta con Ecocardiograma TT que confirma estenosis mitral severa de origen traumático asociado a dilatación auricular izquierda severa, probabilidad alta de HTP y dilatación de aurícula derecha. Pro BNP de 416. fue valorada por parte de cardiología en junta quienes indican toma de eco TE para definir Wilkins y manejo betabloqueador, además paciente requiere manejo quirúrgico por lo que se debe llevar embarazo a las 28 semanas previo a definir conducta dado alto riesgo de muerte fetal y en caso extremo posibilidad de ser necesario protocolo de asistolia fetal. Ingresa a UCI para vigilancia cardiovascular.

REVISIÓN POR SISTEMAS
Sistema neurológico: Normal

EXAMEN FÍSICO

Examen Físico:
Aspecto general
Aspecto general : SIGNOS VITALES

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	

NOTAS MÉDICAS

TA: 92/60 mmHg
TAM: 71 mmHg
FC: 93 Lpm
T°: 36. 1°C
Peso: 53 Kg

CARDIOVASCULAR: Ruidos cardiacos rítmicos. R1 reforzado con soplo mesodiastólico foco mitral.

RESPIRATORIO: Campos pulmonares, sin sobreagregados. Sin soporte de oxígeno, Oxígeno ambiente, FR 12 rpm StO2 94%

GASTROINTESTINAL: Útero grávido, AU 22 ccm, movimientos fetales presentes, FCF 145 lpm.
Fecha de última deposición: 15/02/25 # 1

METABÓLICO: Tolera VO
Glucometria de ingreso 83 mg/dL

INFECCIOSO: Afebril sin sangrados externos

RENAL: Diuresis espontánea
Se indica cuantificación.

EXTREMIDADES: Pulsos ++, móviles, sin edema

SNC: Alerta, consciente, colaborador, Glasgow 15/15
.

Diagnósticos activos después de la nota Diagnóstico de ingreso - I519 - ENFERMEDAD CARDIACA NO ESPECIFICADA (En Estudio), Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, R060 - DISNEA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, Z358 - SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses.

ANÁLISIS DEL CASO Y PLAN DE MANEJO

Análisis del caso: Paciente hemodinámicamente estable, sin soporte vasopresor, en manejo betabloqueador con bisoprolol dad ano disponibilidad de metoprolol. Frecuencias cardiáca en metas. Paciente con estenosis mitral severa y alta probabilidad de hipertensión pulmonar, a la espera de ser llevada a junta materno fetal el día de mañana y junta de cardiología el día 21/02/25 para determinar manejo intervencionista.
Sin soporte de oxígeno, sin disnea, saturaciones adecuadas.
Al ingreso con glucometría en metas, tolera vía oral
Azoados normales, electrolitos normales.
En el momento sin antibiótico, sin fiebre. Se encuentra con indicación de anticoagulación por parte de cardiología.
Feto en buenas condiciones, sin sufrimiento.

Paciente requiere manejo en uci por riesgo de descompensación hemodinámica.
Plan de manejo: PLAN DE MANEJO:
MONITORIA UCI
. Terapia respiratoria cada 6 horas
. Terapia física cada 12 horas
. Rehabilitación cardiaca
. Glucometrias cada 12 horas
. Dieta líquida espesa
. Restricción hídrica de 1200 cc

MEDICAMENTOS:
- Enoxaparina Amp 60 Mg Una Amp Sc Cada 12H
- Bisoprolol 5 Mg Vo Cada 24 Horas

SE SOLICITA
- Paraclínicos de ingreso

EN PROCESO
- Valoración por cardiología
- LLevar a juan maternofetal el 18/02/25

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	

NOTAS MÉDICAS

- Llevar a junta cardiovascular el 21/02/25
- Seguimiento por ginecología

METAS
*EVA -4
* TAM < 65 mmHg.
* FC entre 60 y 80 lpm
* SaO2 mayor a 90%
* Diuresis 1. 0 cc/kg/hora
* T° 36 - 37. 5°C
* Glucometrias entre 140 y 180 mg/dl
* Lactato < 2 mmol/dl
* Potasio entre 3. 8 y 4. 5 mmol /dl
* Fósforo entre 2. 5 y 3. 5 mmol/dl
* Hb > 9 gr/dl
* Plaquetas > 100. 000.

Fecha: 17/02/2025 19:59 - Ubicación: UCI CARDIOVASCULAR
Evolución médica - Interconsultante - CARDIOLOGIA

Condiciones del paciente: Materna
Gesta: 1

ANAMNESIS
Subjetivo: CARDIOLOGIA

pacienet refiere disnea y palpitaciones desde la mañana. Niega dolor toracico o sincope.
Objetivo: TA: 85/55 FC 100 FR : 22 Sato2: 96 % Sin soporte de O2

C/C: Escleras anictericas, mucosas huedas, conjuntivas rosadas. Cuello movil, sin masas o adenopatias. No ingurgitacion yugular
C/P: Torax normoexpansivo, retumbo diastolico en foco mitral sin soplor. Ruidos respiratorios audibles en ambos campos pulmonares sin agregados
Abd: urtero gravido, no doloroso a la palapacion superficial o profunda
Ext: moviles, simetricas, sin edema. Pulsos perifericos ++
SNC Normal

EXAMEN FÍSICO
Escala del dolor: 0.

Diagnósticos activos después de la nota Diagnóstico principal - I519 - ENFERMEDAD CARDIACA NO ESPECIFICADA (En Estudio), Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, R060 - DISNEA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, Z358 - SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses.

ANÁLISIS DEL CASO Y PLAN DE MANEJO

Análisis: Paciente G1P0 con embarazo de 24 semanas con estenosis mitral severa sintomática con alto riesgo quirúrgico. Hoy presenta empeoramiento de disnea sin shock secundario a aumentod e frecuencias cardiacas (reportan 120 lpm). Se realizo EKG donde se identifica taquicardia sinusal a 126 lpm. Se traslado a UCI y se inicio B bloqueador (bisoprolol). Ahora encuentro paciente con persistencia de disnea aunque sin requerimeinto de soporte de O2. Al examen fiscio sin signos de congestión. Se considera:

1. La taquicardia va en deterimento del estado de la paciente dado que afecta llenado diastolico evntricular en paciente con estenosis mitral severa. Se recomienda lograr RAPIDO control de frecuencia cardiaca buscando metas por debajo de 70 lpm. Se puede lograr con metoprolol EV o de no contarse con estre inciiar Bisoprolol 10 mg cada dia. Es vital lograr control de la frecuencia en esta paciente. Se debe mantener anticoagulacion como se indico en la junta del 14/02/2025.
2. Independiente de los signos de congestión clinica, las presiones de llenado en ecocardiograma estan auemntadas por lo que la recomendacion es mantener Furosemida 40 mg EV cada 6 horas y toma de Pro BNP cada 72 horas.

Se comentan estas decisiones con medica de la sala de UCI cardiovascular.

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	

NOTAS MÉDICAS

Plan de manejo: Ver analisis

Justificación de permanencia en el servicio: Manejo en UCI.

Fecha: 18/02/2025 10:55 - Ubicación: UCI CARDIOVASCULAR
Evolución médica - MEDICO INTENSIVISTA

Condiciones del paciente: Materna
Gesta: 1

ANAMNESIS
Subjetivo: * EVOLUCIÓN UCI CARDIOVASCULAR *

FI HUV: 10/02/25
FI UCI CV: 17/02/25

DIAGNÓSTICOS:
1. Estenosis mitral grave de origen reumático
1. 1 EcoTT: V. Max 2. 8m/s, GP: 32 mmHg, GM: 20 mmHg, AVM por VTI 1. 0cm2, THP 164 ms, AVM THP: 1. 3cm2
2. G1P0 - Embarazo de semana 24 semanas
3. Alta probabilidad de hipertensión pulmonar

PROBLEMAS
Riesgo de colapso cardiovascular
Gestación de alto riesgo

ESCALAS
. Ideación suicida: 0 puntos
. APACHE II: 3m puntos, mortalidad 4%
. SOFA DIA 1 (18. 02. 25): 0 puntos, mortalidad 10%

Objetivo: SIGNOS VITALES
TA: 94/60 mmHg
TAM: 71 mmHg
FC: 87 Lpm
T°: 36. 0°C
Peso: 53 Kg

CARDIOVASCULAR: Ruidos cardiacos rítmicos. R1 reforzado con soplo mesodiastólico foco mitral.

RESPIRATORIO: Campos pulmonares, sin sobreagregados. Sin soporte de oxígeno, Oxígeno ambiente, FR 14 rpm StO2 98%

GASTROINTESTINAL: Útero grávido, AU 22 ccm, movimientos fetales presentes, FCF 145 lpm.
Fecha de última deposición: Desconocida

METABÓLICO: Tolera VO
Glucometria: 83-91-82 mg/dL

INFECCIOSO: Afebril sin sangrados externos

RENAL: Diuresis espontánea

NOTAS MÉDICAS

EXTREMIDADES: Pulsos ++, móviles, sin edema

SNC: Alerta, consciente, colaborador, Glasgow 15/15

EXAMEN FÍSICO
Escala del dolor: 0.

Diagnósticos activos después de la nota Diagnóstico principal - I519 - ENFERMEDAD CARDIACA NO ESPECIFICADA (En Estudio), Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, R060 - DISNEA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, Z358 - SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses.

ANÁLISIS DEL CASO Y PLAN DE MANEJO

Análisis: Paciente hemodinámicamente estable, sin soporte vasopresor, en manejo betabloqueador con bisoprolol dada no disponibilidad de metoprolol. Frecuencias cardiáca en metas. Paciente con estenosis mitral severa y alta probabilidad de hipertensión pulmonar, a la espera de ser llevada a junta materno fetal y de cardiologia para definir conducta.

Sin soporte de oxígeno, sin disnea, saturaciones adecuada, con frecuencia cardiaca en metas.

Al ingreso con glucometría en metas, tolera vía oral
Azoados normales, electrolitos normales.
En el momento sin antibiótico, sin fiebre. Se encuentra con indicación de anticoagulación por parte de cardiología.
Feto en buenas condiciones, sin sufrimiento.

Paciente requiere manejo en uci por riesgo de descompensación hemodinámica, y riesgo de muerte fetal, se considera continuar manejo medico instaurado, continua monitorizacion UCIN.

Plan de manejo: MONITORIA UCI
. Terapia respiratoria cada 6 horas
. Terapia física cada 12 horas
. Rehabilitación cardiaca
. Glucometrias cada 12 horas
. Dieta líquida espesa
. Restricción hídrica de 1200 cc

MEDICAMENTOS:
- Enoxaparina Amp 60 Mg Una Amp Sc Cada 12H
- Bisoprolol 10 Mg Vo Cada 24 Horas.
- Furosemida 40 mg IV cada 6 horas.
- Lorazepam 0. 5 mg cada noche **nuevo**

SE SOLICITA

- Bro Bnp cada 72 h

EN PROCESO

- Llevar a juan maternofetal el 18/02/25
- Llevar a junta cardiovascular el 21/02/25
- Seguimiento por ginecología, cardiologia

METAS
*EVA -4
* TAM > 65 mmHg.
* FC entre <70 lpm
* SaO2 mayor a 90%
* Diuresis 1. 0 cc/kg/hora
* T° 36 - 37. 5°C
* Glucometrias entre 140 y 180 mg/dl
* Lactato < 2 mmol/dl

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	

NOTAS MÉDICAS

* Potasio entre 3. 8 y 4. 5 mmol /dl
* Fósforo entre 2. 5 y 3. 5 mmol/dl
* Hb > 9 gr/dl
* Plaquetas > 100. 000

Justificación de permanencia en el servicio: uci por riesgo de descompensación hemodinámica, y riesgo de muerte feta.

Fecha: 18/02/2025 11:17 - Ubicación: UCI CARDIOVASCULAR
Evolución médica - GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Condiciones del paciente: Materna
Gesta: 1

ANAMNESIS

DIAGNÓSTICOS
1. G1P0
2. EMBARAZO DE 24, 5 SEMANAS POR ECOGRAFÍA 12/11/2024 10. 5
3. DISNEA EN ESTUDIO
 3. 1. ESTENOSIS MITRAL SEVERA DE ORIGEN REUMÁTICO
 3. 2. ALTA PROBABILIDAD DE HIPERTENSIÓN PULMONAR

PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN NO HA PRESENTADO NUEVA SINTOMATOLOGÍA. AHORA SIN DISNEA. SIN DOLOR PRECORDIAL. SIN OTRA SINTOMATOLOGIA ASOCIADA.

Objetivo: SIGNOS VITALES: TA: 115/63 MMHG, // FC: 80 LPM, // FR: 16 RPM, // T°: 36°C, // SO2: 97%
BUENAS CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, CONJUNTIVAS PÁLIDAS, ROSADAS
C/P RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS SOPLO HOLOSISTÓLICO EN FOCO MITRAL, MV CONSERVADO SIN SOBREAGREGADOS
ABDOMEN ÚTERO GRÁVIDO, AU: 22 CM, FUVCDI, MOVIMIENTOS FETALES PRESENTES, NO ACTIVIDAD UTERINA, NO DOLOR FCF: 140 LPM
G/U SIN SANGRADO, NO AMNIORREA, SE OMITE TV
LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS.
DIURESIS ESPONTÁNEA NO CUANTIFICADA

EXAMEN FÍSICO
Escala del dolor: 0.

Diagnósticos activos después de la nota Diagnóstico principal - I519 - ENFERMEDAD CARDIACA NO ESPECIFICADA (En Estudio), Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, R060 - DISNEA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, Z358 - SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses.

ANÁLISIS DEL CASO Y PLAN DE MANEJO

Análisis: PACIENTE DE 20 AÑOS G1P0 CON EMBARAZO DE 24, 5 SEMANAS, HOSPITALIZADA EN CONTEXTO DE:

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	

NOTAS MÉDICAS

1. ESTENOSIS MITRAL SEVERA DE ORIGEN REUMATICA: HISTORIA DE DISMINUCION DE LA CLASE FUNCIONAL, CON ECO TE 14/02/2025 CON ENFERMEDAD REUMÁTICA DE LA VÁLVULA MITRAL, CON ESTENOSIS DE GRADO SEVERO E INSUFICIENCIA DE GRADO LEVE, DILATACIÓN SEVERA DE LA AURÍCULA IZQUIERDA. Y ALTA PROBABILIDAD DE HIPERTENSIÓN PULMONAR CON PROBNP DE 416. VALORADA POR:
1. JUNTA CARDIOQUIRURGICA QUIENES CONSIDERAN DX DE ESTENOSIS MITRAL SEVERA SINTOMATICA CON INDICACION DE MANEJO QUIRURGICO CON TIEMPO QURURGICO CON ALTO RIESGO DE COMPLICACION. POSIBILIDAD DE ANGIOPLASTIA PERCUTÁNEA CON BALÓN VS VALVULOTOMIA. DADO EL ALTO RIESGO QUE TIENE LA INTERVENCIÓN EN EL EMBARAZO, REQUIERE DE VALORACIÓN MULTIDISCIPLINARIA EN CONJUNTO CON LA DECISIÓN DE LA PACIENTE. INDICAN POR EL MOMENTO MANEJO EXPECTANTE CON ANTIHIPERTENSIVO, ANTICOAGULACION Y DIURETICO.
2. COMITE MATERNO FETAL CON PARTICIPACION DE CARDIOLOGIA, NEONATOLOGIA Y MEDICINA MATERNOFETAL. CON INDICACION DE MANEJO EXPECTANTE, CONTINUAR CON MANEJO ANTIHIPERTENSIVO + ANTICOAGULACION Y DIURETICO Y MONITORIA ESTRICTA DE SV MATERNOS Y FETOCARDIA. (PENDIENTE NOTA OFICIAL)

AYER CON EPISODIO DE DISNEA CON EMPEORAMIENTO DE LA MISMA SIN SHOCK. AHORA CON SIGNOS VITALES ESTABLES, SIN DISNEA, SIN DESATURACION. FETOCARDIA PRESENTE AUDIBLE.
SE TRATA DE PACIENTE CON ALTO RIESGO DE COMPLICACION MATERNA Y FETAL. SE INDICA CONTINUAR EN MANEJO CONJUNTO EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS CON MONITORIA CONTINUA DE SIGNOS VITALES SE CONTINUARA MANEJO EXPECTANTE DE ACUERDO A EVOLUCION.
SE HABLA EN CONJUNTO CON RESTO DE ESPECIALIDADES (CARDIOLOGIA, NEONATOLOGIA Y GINECOLOGIA) CON LA PACIENTE, SE PLANTEAN POSIBILIDADES DE MANEJO Y PRONOSTICOS TANTO MATERNOS COMO FETALES. POR EL MOMENTO ACEPTA MANEJO EXPECTANTE ESTRICTO PROPUESTO.

Plan de manejo: PLAN DE MANEJO:
MONITORIA UCI
. TERAPIA RESPIRATORIA CADA 6 HORAS
. TERAPIA FÍSICA CADA 12 HORAS
. REHABILITACIÓN CARDIACA
. GLUCOMETRIAS CADA 12 HORAS
. DIETA LÍQUIDA ESPESA
. RESTRICCIÓN HÍDRICA DE 1200 CC

MEDICAMENTOS:
- ENOXAPARINA AMP 60 MG UNA AMP SC CADA 12H
- BISOPROLOL 10 MG VO CADA 24 HORAS
FUROSEMIDA 40 MG CADA 6 HORAS

SE SOLICITA
- PROBNP CADA 72H

EN PROCESO
- LLEVAR A JUNTA CARDIOVASCULAR EL 21/02/25
- SEGUIMIENTO ESTRICTO MATERNO Y FETAL
-PENDIENTE NOTA OFICIAL COMITE MATERNO FETAL

Justificación de permanencia en el servicio: PACIENTE CON ALTO RIESGO DE COMPLICACION.

Fecha: 18/02/2025 11:18 - Ubicación: UCI CARDIOVASCULAR
Evolución médica - Apoyo - CARDIOLOGIA

Condiciones del paciente: Materna
Gesta: 1

ANAMNESIS
Subjetivo: CARDIOLOGÍA CLÍNICA

NOTAS MÉDICAS

Objetivo: FC: 80 TA: 110/70

EXAMEN FÍSICO
Frecuencia cardíaca(Lat/min): 80 Pulso(Pulsa/min): 80 Frecuencia respiratoria(Respi/min): 18
Saturación de oxígeno 99%, sin oxígeno
Escala del dolor: 0

Examen Físico:
Aspecto general
Aspecto general : Normal

Diagnósticos activos después de la nota Diagnóstico principal - I519 - ENFERMEDAD CARDIACA NO ESPECIFICADA (En Estudio), Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, R060 - DISNEA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, Z358 - SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, I050 - ESTENOSIS MITRAL, Fecha de diagnóstico: 18/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses.

ANÁLISIS DEL CASO Y PLAN DE MANEJO

Análisis: Paciente conocida con estenosis mitral reumática severa sintomática y embarazo de 24 semanas que con la progresión de la gestación ha empeorado la manifestación clínica de la valvulopatía. La paciente no aceptó interrupción del embarazo. Enecocardiograma el score de Wilkins es desfaorable para intervención con valvulotomía por alto riesgo de complicaciones dado estado avanzado de la patología reumática. Actualmente en mejor estado general con el inicio de terapia diurética y el aumento del betabloqueador. La encontramos en cama, tranquila, sin requerimiento de suplemento de oxígeno, sin agregados pulmonares. Hoy en reunión con gineco-obstetricia y neonatología se considera realizar seguimiento clínico estrecho en conjunto con el objetivo de llevar a la semana 28 para en el mismo tiempo quirúrgico realizar cesarea y reemplazo valvular mitral abierto. Se realizará proBNP cada 72 horas. Se solicita a ginecología realizar ecografía obstétrica cada 72 horas para descartar oligoamnios y guiar terapia diurética en términos de reducir dosis de furosemida si se presenta. En caso de que su estado clínico empeore se evaluará adelantar procedimiento de cesarea y reemplazo valvular abierto o en un caso extremo se realizará valvulotomía con balón percutánea con respaldo de cirugía cardiovascular con los riesgos que implica el procedimiento con un score de Wilkins desfavorable. En caso de novedades clínicas contactar a cualquier hora al Dr. Sebastián Ayala (Fellow de cardiología encargado).

Plan de manejo: - Ecografía obstétrica por ginecología cada 72 horas (evaluar presencia de oligoamnios)
- proBNP cada 72 horas
- Bisoprolol 10mg VO día
- Furosemida 20mg IV cada 6 horas
- Enoxaparina 1mg sc kg cada 12 hors

Justificación de permanencia en el servicio: Estancia en UCI.

Fecha: 18/02/2025 12:45 - Ubicación: UCI CARDIOVASCULAR
Evolución médica - Interconsultante - PSIQUIATRA

Condiciones del paciente: Materna
Gesta: 1

ANAMNESIS

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	

NOTAS MÉDICAS

r

Motivo de interconsulta: "paciente con poca respuesta verbal, en ocasiones mutista. al parecer no es consciente de su patología a pesar de que se le ha explicado su patología, los riesgos y posibles complicaciones tanto maternas como fetales; incluido muerte materna y/o fetal. en horas de la mañana se torno ansiosa y manifestó deseos de egreso; además que la pareja no ha podido recibir visita periódica de su pareja por su horario laboral y otras ocupaciones se solicita valoración por psicología, trabajo social, psiquiatría"

Enfermedad actual:
Paciente de 20 años, con embarazo de 24. 5 semanas con diagnóstico de novo de ?? estenosis mitral reumática severa sintomática, en seguimiento por cardiología quienes considera no es candidata valvulotomía por alto riesgo de complicaciones dado estado avanzado de la patología reumática. Paciente que manifiesta deseos de continuar con el embarazo pese a que se le ha informado de manera amplia y clara las complicaciones maternas y fetales, adicionalmente se torna ansiosa y manifestó deseos de egreso, por lo que solicitan concepto.

Encontramos paciente alerta, tranquila, orientada, lacónica en su discurso, con respecto a su patología manifiesta "ya no quiero hablar de eso, he hablado mucho de eso", niega ideas de muertes, suicidas, auto o hetero agresion, sin problemas para coniliar el sueño, refiere en ocasiones sentirse ansiosa, dice "me dan ganas de pararme de la cama, me quiero ir". En el momento sin acompañante, su único apoyo en la ciudad en su pareja, está a la espera de la llegada de su madre desde barbacoa, Nariño para que acompañe su proceso de hospitalización

Antecedentes
- Patológicos: Anemia
- Farmacológicos: niega
- Quirúrgicos: niega
- Alérgicos: niega
- Traumatológicos: niega
- Toxicológicos: niega
- Familiares: niega

ANTECEDENTES DE RELEVANCIA EN SALUD MENTAL
Experiencias emocionalmente perturbadoras: niega
Factores de riesgo: red de apoyo con domicilio lejano, diagnóstico reciente de patología crónica
Factores protectores: acceso a servicio de salud.

Objetivo: Examen mental:
- Aspecto: paciente en la tercera década de la vida, aparenta menor edad cronológica y contextura delgada, luce organizada en su presentación personal, establece contacto visual y verbal con entrevistadora
- Actitud: prevenida
- Psicomotor: euquinético
- Afecto: eutímico
- Pensamiento:
*Curso: coherente, lacónica, volumen de voz disminuido, intervalo pregunta respuesta adecuado, producción ideoverbal disminuida al momento de la entrevista.
*Contenido: niega ideas de muerte, niega ideas suicidas, o de auto o hetero agresión, no verbaliza delirios en el momento de la entrevista
*Forma: lógico.
- Sensopercepción: no refiere alucinaciones ni ilusiones
- Sensorio: alerta, orientada en tiempo, lugar y persona, euproséxico, memoria conservada.
- Juicio de la realidad: conservado.

EXAMEN FÍSICO
Escala del dolor: 0.

Diagnósticos activos después de la nota Diagnóstico principal - I519 - ENFERMEDAD CARDIACA NO ESPECIFICADA (En Estudio), Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, R060 - DISNEA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, Z358 - SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, I050 - ESTENOSIS MITRAL, Fecha de diagnóstico: 18/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses.

ANÁLISIS DEL CASO Y PLAN DE MANEJO

NOTAS MÉDICAS

Análisis: Paciente de 20 años, con embarazo de 24. 5 semanas con diagnóstico de novo de ?? estenosis mitral reumática severa sintomática, en seguimiento por cardiología quienes considera no es candidata valvulotomía por alto riesgo de complicaciones dado estado avanzado de la patología reumática.

Ahora en mejor estado general con manejo por parte de equipo uci y cardiología, debido que la paciente no desea finalizar el embarazo pese a posibles complicaciones con desenlaces fatales maternos o fetales, se propone por equipo multidisciplinario realizar seguimiento estrecho con el objetivo delegar a la semana 28 de gestación para en el mismo tiempo quirúrgico realizar cesárea y reemplazo valvular mitral abierto. En caso de que su estado clínico empeore se evaluará adelantar procedimientos.

Por parte de psiquiatría se encuentra paciente sin alteraciones en el afecto o pensamiento, sin embargo, días previos con picos ansiosos, ha verbalizado deseo de egreso, "me quiero bajar de esta cama. ". Se comenta con cardiología quienes refieren paciente que se torna ansiosa con información sobre su patología lo cual genera aumento en frecuencia cardiaca y no es conveniente por su condición, dado lo anterior se indica iniciar ciclo corto de benzodiacepinas a dosis bajas en las noches, con lo que se manejan síntomas ansiosos y coadyuvante para el sueño.
No hay un compromiso en el juicio para la toma de decisiones médicas.

Por el momento sin más intervenciones por psiquiatría, se cierra IC. Quedamos atentos a nuevos llamados

Plan de manejo: -Lorazepam tabletas de 1 mg, dar media tableta (0. 5 mg) a las 20+00 por 7 días.

Justificación de permanencia en el servicio: Se cierra IC.

Fecha: 18/02/2025 22:00 - Ubicación: UCI CARDIOVASCULAR
Evolución médica - Apoyo - MEDICINA INTERNA INTENSIVISTA

Condiciones del paciente: Materna
Gesta: 1

ANAMNESIS
Subjetivo: **EVOLUCIÓN UCI CARDIOVASCULAR NOCHE**

FI HUV: 10/02/25
FI UCI CV: 17/02/25

DIAGNÓSTICOS:
1. Estenosis mitral grave de origen reumático
2. G1P0 - Embarazo de semana 24 semanas
3. Alta probabilidad de hipertensión pulmonar

PROBLEMAS
Riesgo de colapso cardiovascular
Gestación de alto riesgo

ESCALAS
. Ideación suicida: 0 puntos
. APACHE II: 3m puntos, mortalidad 4%
. SOFA DIA 1 (18. 02. 25): 0 puntos, mortalidad 10%

Objetivo: EXAMEN FÍSICO:

NOTAS MÉDICAS

SIGNOS VITALES
TA: 89/54 mmHg
TAM: 65 mmHg
FC: 85 Lpm
T°: 36. 7°C
Peso: 53 Kg

CARDIOVASCULAR: Ruidos cardiacos rítmicos. R1 reforzado con soplo mesodiastólico foco mitral.

RESPIRATORIO: Campos pulmonares, sin sobreagregados. Sin soporte de oxígeno, FR 16 rpm StO2 97%

GASTROINTESTINAL: Útero grávido, AU 22 ccm, movimientos fetales presentes, FCF 145 lpm.
Fecha de última deposición: Desconocida

METABÓLICO: Tolera VO
Glucometria: 89-97-100 mg/dL

INFECCIOSO: Afebril sin sangrados externos

RENAL: Diuresis espontánea, balance dia -550 cc.

EXTREMIDADES: Pulsos ++, móviles, sin edema

SNC: Alerta, consciente, colaborador, Glasgow 15/15

EXAMEN FÍSICO
Escala del dolor: 0.

Diagnósticos activos después de la nota Diagnóstico principal - I519 - ENFERMEDAD CARDIACA NO ESPECIFICADA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, R060 - DISNEA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, Z358 - SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, I050 - ESTENOSIS MITRAL, Fecha de diagnóstico: 18/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses.

ANÁLISIS DEL CASO Y PLAN DE MANEJO

Consentimiento informado: Requiere Lo tiene

Análisis: ANALISIS:
Paciente de 20 años, en contexto de Estenosis mitral grave de origen reumático, con embarazo de 24 semanas. En junta cardio/gineco se le viene haciendo seguimiento quienes indican continuar anticoagulada y manejo depletivo y ecografico para evaluar oligohidramnios, ademas se plante posibilidad de llevar embarazo hasta 28 semanas y realizar cesarea + reemplazo valvular. Por el moemnto paciente con cifras tensionales y frecuencias cardiacas controaldas, sin soprote de oxigeno, saturacion adecuada, percibe movimientos fetales. Por el moemnto continua vigilancia en UCI con alto riesgo de complicaciones materno/fetales.

Plan de manejo: PLAN DE MANEJO:
MONITORIA UCI
. Terapia respiratoria cada 6 horas
. Terapia física cada 12 horas
. Rehabilitación cardiaca
. Glucometrias cada 12 horas
. Dieta líquida espesa
. Restricción hídrica de 1200 cc

MEDICAMENTOS:
- Enoxaparina Amp 60 Mg Sc Cada 12H
- Bisoprolol 10 Mg Vo Cada 24 Horas
- Furosemida 40 mg IV cada 6 horas
- Lorazepam 0. 5 mg cada noche

EN PROCESO
- Ecografía obstétrica por ginecología cada 72 horas (evaluar presencia de oligoamnios)
- Bro Bnp cada 72 h
- Llevar a junta cardiovascular el 21/02/25
- Seguimiento por ginecología, cardiología

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	

NOTAS MÉDICAS

Justificación de permanencia en el servicio: JSUTIFICACION UCI:
. Monitoria hemodinamcia invasiva
. Alto riesgo obstetrico.

Fecha: 19/02/2025 00:45 - Ubicación: UCI CARDIOVASCULAR
Evolución médica - GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Condiciones del paciente: Materna
Gesta: 1

ANAMNESIS
Subjetivo: NOTA DE EVOLUCION GINECOLOGIA
PACIENTE DE 20 AÑOS CON LOS SIGUIENTES DIAGNOSTICOS

1. G1P0
2. EMBARAZO DE 24, 5 SEMANAS POR ECOGRAFÍA 12/11/2024 10. 5
3. DISNEA EN ESTUDIO
3. 1. ESTENOSIS MITRAL SEVERA DE ORIGEN REUMÁTICO
3. 2. ALTA PROBABILIDAD DE HIPERTENSIÓN PULMONAR

SUB: PACIENTE EN EL MOMENTO TRANQUILA NIEGA DOLOR TORAICICO NIEG DISNEA NIEGA SINTOMAS PREMONITORIOS NIEGA PERDIAS VAGINALES, NIEGA ACTIVIDAD UTERINA, REFIRE SENTIR ADECUADAMENTE MOVIMIENTOS FETALES

Objetivo: PRESENTA LOS SIGUIENTES SIGNOS VITALES
PA: 96/64 MMHG FC: 76 T: 36. 6 FR: 16 FCF 143

EXAMEN FÍSICO
Escala del dolor: 0

Examen Físico:
Aspecto general
Aspecto general : BUENAS CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, CONJUNTIVAS PÁLIDAS, ROSADAS
CARDIOPULMONAR. RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS SOPLO HOLOSISTÓLICO EN FOCO MITRAL, MV CONSERVADO SIN SOBREAGREGADOS
ABDOMEN ÚTERO GRÁVIDO, AU: 22 CM, MOVIMIENTOS FETALES PRESENTES, NO ACTIVIDAD UTERINA, NO DOLOR FCF: 143 LPM
G/U SIN SANGRADO, NO AMNIORREA, SE OMITE TV
LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS.
DIURESIS ESPONTÁNEA NO CUANTIFICADA
SNC PACIENTE ALERTA.

Diagnósticos activos después de la nota Diagnóstico principal - I519 - ENFERMEDAD CARDIACA NO ESPECIFICADA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, R060 - DISNEA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, Z358 - SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, I050 - ESTENOSIS MITRAL, Fecha de diagnóstico: 18/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses.

ANÁLISIS DEL CASO Y PLAN DE MANEJO

Análisis: PACIENTE DE 20 AÑOS G1P0 CON EMBARAZO DE 24, 5 SEMANAS, HOSPITALIZADA EN CONTEXTO DE:

1. ESTENOSIS MITRAL SEVERA DE ORIGEN REUMATICA: HISTORIA DE DISMINUCION DE LA CLASE FUNCIONAL, CON ECO TE 14/02/2025 CON ENFERMEDAD REUMÁTICA DE LA VÁLVULA MITRAL, CON ESTENOSIS DE GRADO SEVERO E INSUFICIENCIA DE GRADO LEVE, DILATACIÓN SEVERA DE LA AURÍCULA IZQUIERDA. Y ALTA PROBABILIDAD DE HIPERTENSIÓN PULMONAR CON PROBNP DE 416. VALORADA POR:
1. JUNTA CARDIOQUIRURGICA QUIENES CONSIDERAN DX DE ESTENOSIS MITRAL SEVERA SINTOMATICA CON INDICACION DE MANEJO QUIRURGICO CON TIEMPO QURURGICO CON ALTO RIESGO DE COMPLICACION. POSIBILIDAD DE ANGIOPLASTIA

NOTAS MÉDICAS

PERCUTÁNEA CON BALÓN VS VALVULOTOMIA. DADO EL ALTO RIESGO QUE TIENE LA INTERVENCIÓN EN EL EMBARAZO, REQUIERE DE VALORACIÓN MULTIDISCIPLINARIA EN CONJUNTO CON LA DECISIÓN DE LA PACIENTE. INDICAN POR EL MOMENTO MANEJO EXPECTANTE CON ANTIHIPERTENSIVO, ANTICOAGULACION Y DIURETICO.

2. COMITE MATERNO FETAL CON PARTICIPACION DE CARDIOLOGIA, NEONATOLOGIA Y MEDICINA MATERNOFETAL. CON INDICACION DE MANEJO EXPECTANTE, CONTINUAR CON MANEJO ANTIHIPERTENSIVO + ANTICOAGULACION Y DIURETICO Y MONITORIA ESTRICTA DE SV MATERNOS Y FETOCARDIA. (PENDIENTE NOTA OFICIAL)

AHORA CON SIGNOS VITALES ESTABLES, SIN DISNEA, SIN DESATURACION. FETOCARDIA PRESENTE AUDIBLE.

PACIENTE CON ALTO RIESGO DE COMPLICACION MATERNA Y FETAL. SE INDICA CONTINUAR EN MANEJO CONJUNTO EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS CON MONITORIA CONTINUA DE SIGNOS VITALES SE CONTINUARA MANEJO EXPECTANTE DE ACUERDO A EVOLUCION.

SE HABLA EN CONJUNTO CON RESTO DE ESPECIALIDADES (CARDIOLOGIA, NEONATOLOGIA Y GINECOLOGIA) CON LA PACIENTE, SE PLANTEAN POSIBILIDADES DE MANEJO Y PRONOSTICOS TANTO MATERNOS COMO FETALES. POR EL MOMENTO ACEPTA MANEJO EXPECTANTE ESTRICTO PROPUESTO.

Plan de manejo: CONTINUA TERAPIA Y VIGILANCIA EN UCI

Justificación de permanencia en el servicio:.

--REGISTRO PENDIENTE DE AVAL--

Fecha: 19/02/2025 08:23 - Ubicación: UCI CARDIOVASCULAR
Evolución médica - MEDICO INTENSIVISTA

Condiciones del paciente: Materna
Gesta: 1

ANAMNESIS
Subjetivo: niega dolor o molestias refiere movimientos fetales niega contracciones
Objetivo: **EVOLUCIÓN UCI CARDIOVASCULAR**

FI HUV: 10/02/25
FI UCI CV: 17/02/25

DIAGNÓSTICOS:
1. Estenosis mitral grave de origen reumático
2. G1P0
 - Embarazo 24. 3 semanas
3. Alta probabilidad de hipertensión pulmonar

PROBLEMAS
Riesgo de colapso cardiovascular
Gestación de alto riesgo

ESCALAS
. Ideación suicida: 0 puntos
. APACHE II: 3 puntos, mortalidad 4%

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	

NOTAS MÉDICAS

. SOFA DIA 1 (18. 02. 25): 0 puntos
. SOFA DIA 2 (19. 02. 25): 1 punto mortalidad 0%

EXAMEN FÍSICO
Escala del dolor: 0

Examen Físico:
Aspecto general
Aspecto general : TA: 92/57 mmHg
TAM: 68 mmHg
FC: 90 Lpm
T°: 36. 1°C
Peso: 53 Kg

CARDIOVASCULAR: Ruidos cardiacos rítmicos. R1 reforzado con soplo mesodiastólico foco mitral.

RESPIRATORIO: Campos pulmonares, sin sobreagregados. Sin soporte de oxígeno, FR 20 rpm StO2 96%

GASTROINTESTINAL: Útero grávido, AU 22 ccm, movimientos fetales presentes, FCF 143 lpm.
Fecha de última deposición: Desconocida

METABÓLICO: Tolera VO
Glucometria: 89-97-200- 95- mg/dL

INFECCIOSO: Afebril sin sangrados externos

RENAL: Diuresis espontánea,
GU 1. 7 cc/k/h 12 h balance dia -1000 cc.
Acumulado -2500 cc

EXTREMIDADES: Pulsos ++, móviles, sin edema

SNC: Alerta, consciente, colaborador, Glasgow 15/15.

Diagnósticos activos después de la nota Diagnóstico principal - I519 - ENFERMEDAD CARDIACA NO ESPECIFICADA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, R060 - DISNEA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, Z358 - SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, I050 - ESTENOSIS MITRAL, Fecha de diagnóstico: 18/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses.

ANÁLISIS DEL CASO Y PLAN DE MANEJO

Análisis: Paciente de 20 años de edad sin antecedentes de importancia, cursando con embarazo de 24 ss quien consulta por cuadro de disnea progresiva, con lo cual se le realiza Eco TE que evidencia FEVI del 60% con Enfermedad reumática de la válvula mitral, con estenosis de grado severo e insuficiencia de grado leve y probabilidad alta de Hipertensión Pulmonar, evolución clínica estacionaria en vigilancia UCI con los siguientes problemas.
. Paciente hemodinámicamente estable, sin soporte vasopresor, en manejo betabloqueador con bisoprolol con FC en metas. Paciente con estenosis mitral severa y alta probabilidad de hipertensión pulmonar con indicación quirúrgica, quien en junta de especialidades se llegó a conclusión de continuar manejo expectante hasta las 28 ss, por lo cual se encuentra en manejo médico y vigilancia estricta. Control de ProBnp 484 sin signos clínicos de congestión.
. Sin soporte de oxígeno, sin disnea, saturaciones adecuada.
. Tolera VO con glucometría en metas.
. Diuresis espontánea con balance negativo, se ajusta diuretico de asa a 20mg cada 6 horas. Azoados normales, hiponatremia leve k en normalidad
. En el momento sin antibiótico, sin fiebre.
. Feto en buenas condiciones, sin sufrimiento, seguimiento por G/O.
. Anemia leve, leucocitos y plts en normalidad con indicación de anticoagulación con heparinas de BPM

Paciente con Estenosis Mitral Severa con adecuada evolución, estable hemodinámicamente, se indica continuar monitorización UCIN por riesgo de descompensación hemodinámica y riesgo de muerte fetal, se considera continuar manejo médico instaurado. Se explica conducta a paciente y familiar quien refiere entender y aceptar.

Plan de manejo: PLAN DE MANEJO:
MONITORIA UCIN

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE		

NOTAS MÉDICAS

. Terapia respiratoria cada 6 horas
. Terapia física cada 12 horas
. Rehabilitación cardiaca
. Glucometrias cada 12 horas
. Dieta líquida espesa
. Restricción hídrica de 1200 cc

MEDICAMENTOS:
- Enoxaparina 60 Mg Sc Cada 12 Horas
- Bisoprolol 10 Mg Vo Cada 24 Horas
- Furosemida 20 mg IV cada 6 horas
- Lorazepam 0. 5 mg cada noche

EN PROCESO
- Ecografía obstétrica por ginecología cada 72 horas (evaluar presencia de oligoamnios)
- Pro Bnp cada 72 h
- Llevar a junta cardiovascular el 21/02/25
- Seguimiento por ginecología, cardiología

METAS
*EVA -4
* TAM > 65 mmHg.
* FC entre <70 lpm
* SaO2 mayor a 90%
* Diuresis 1. 0 cc/kg/hora
* T° 36 - 37. 5°C
* Glucometrias entre 140 y 180 mg/dl
* Lactato < 2 mmol/dl
* Potasio entre 3. 8 y 4. 5 mmol /dl
* Fósforo entre 2. 5 y 3. 5 mmol/dl
* Hb > 9 gr/dl
* Plaquetas > 100. 000

Justificación de permanencia en el servicio: MONITORIA HEMODINAMICA CONTINUA
RIESGO DE INESTABILIDAD EMODINAMICA
RIESGO DE PERDIDA DEL EMBARAZO.

Fecha: 19/02/2025 11:22 - Ubicación: UCI CARDIOVASCULAR
Evolución médica - GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Condiciones del paciente: Materna
Gesta: 1

DIAGNÓSTICOS

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	

NOTAS MÉDICAS

1. G1P0
2. EMBARAZO DE 24, 6 SEMANAS POR ECOGRAFÍA 12/11/2024 10. 5
3. DISNEA EN ESTUDIO
 3. 1. ESTENOSIS MITRAL SEVERA DE ORIGEN REUMÁTICO
 3. 2. ALTA PROBABILIDAD DE HIPERTENSIÓN PULMONAR

PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN NO HA PRESENTADO NUEVA SINTOMATOLOGÍA. AHORA SIN DISNEA. SIN DOLOR PRECORDIAL. SIN OTRA SINTOMATOLOGIA ASOCIADA.

Objetivo: PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN NO HA PRESENTADO NUEVA SINTOMATOLOGÍA. AHORA SIN DISNEA. SIN DOLOR PRECORDIAL. SIN OTRA SINTOMATOLOGIA ASOCIADA.

SIGNOS VITALES: TA: 110/63 MMHG, // FC: 90 LPM, // FR: 18 RPM, // T°: 36°C, // SO2: 96% CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO POR CANULA 1L/MIN.
BUENAS CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, CONJUNTIVAS PÁLIDAS, ROSADAS
C/P RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS SOPLO HOLOSISTÓLICO EN FOCO MITRAL, MV CONSERVADO SIN SOBREAGREGADOS
ABDOMEN ÚTERO GRÁVIDO, AU: 22 CM, FUVCDI, MOVIMIENTOS FETALES PRESENTES, NO ACTIVIDAD UTERINA, NO DOLOR FCF: 153 LPM
G/U SIN SANGRADO, NO AMNIORREA, SE OMITE TV
LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS.
DIURESIS ESPONTÁNEA NO CUANTIFICADA

EXAMEN FÍSICO
Escala del dolor: 0.

Diagnósticos activos después de la nota Diagnóstico principal - I519 - ENFERMEDAD CARDIACA NO ESPECIFICADA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, R060 - DISNEA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, Z358 - SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, I050 - ESTENOSIS MITRAL, Fecha de diagnóstico: 18/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses.

ANÁLISIS DEL CASO Y PLAN DE MANEJO

Análisis: PACIENTE DE 20 AÑOS G1P0 CON EMBARAZO DE 24, 6 SEMANAS, HOSPITALIZADA EN CONTEXTO DE:

1. ESTENOSIS MITRAL SEVERA DE ORIGEN REUMATICA: HISTORIA DE DISMINUCION DE LA CLASE FUNCIONAL, CON ECO TE 14/02/2025 CON ENFERMEDAD REUMÁTICA DE LA VÁLVULA MITRAL, CON ESTENOSIS DE GRADO SEVERO E INSUFICIENCIA DE GRADO LEVE, DILATACIÓN SEVERA DE LA AURÍCULA IZQUIERDA. Y ALTA PROBABILIDAD DE HIPERTENSIÓN PULMONAR CON PROBNP DE 484. VALORADA POR:
1. JUNTA CARDIOQUIRURGICA + MATERNOFETAL: PACIENTE CON ESTENOSIS MITRAL REUMATICA SEVERA SINTOMATICA CON EMPEORAMIENTO DE SINTOMATOLOGIA POR PROGRESION DE LA GESTACION. CON INDICACION DE MANEJO EXPEXTANTE HASTA LAS 28 SEMANAS, FINALIZACION POR CESAREA Y EN MISMO TIEMPO QUIRURGICO CORRECCION DE VALVULA. CON ECO TE CON SCORE DE WILKINS DESFAVORABLE PARA INTERVENCION CON VALVULOTOMIA. CON PLAN DE REEMPLAZO VALVULAR ABIERTO O EN CASO EXTREMO VALVULOTOMIA CON BALON PERCUTANEO CON RESLPADO DE CX CARDIOVASCULAR CON LOS RIESGOS QUE IMPLICA EL PROCEDIMIENTO CON SCORE DE WILKINS DESFAVORABLE. AHORA EN MANEJO CON BISOPROLOL, FUROSEMIDA Y ANTICOAGULACION. EN EL MOMENTO CON ESTABILIDAD HEMODINAMICA. SV ESTABLES CONR EQUERIMIENTO DE OXIGENO A 1L MINUTO DESDE EL DIA DE HOY.

POR PARTE DE CARDIOLOGIA CON INDICACION DE SEGUIMIENTO CON ECOGRAFIA OBSTETRICA CADA 72 HORAS PARA DESCARTAR OLIGOAMNIOS Y GUIAR TERAPIA DIURETICA. SE CONSIDERA PACIENTE CON EMBARAZO EN LIMITE DE VIABILIDAD. SE INDICA POR PARTE DE PERINATOLOGIA RASTREO ECOGRAFICO EN CASO DE SER NECESARIO. Y EN CASO DE REQUERIR ECOGRAFIA FORMAL DEBERA REALIZARSE EN SEPTIMO PISO CON EQUIPOS PARA BIOMETRIA FETAL. SIN EMBARGO, DADA EDAD GESTACIONAL CON POCAS HERRAMIENTAS PARA OGFRECER EN CASO DE OLIHGOHIDRAMNIOS DONDE DADO ALTO RIESGO DE COMPLICACION MATERNA SE DEBERA EVALUAR RIESGO BENEFICIO DE AJUSTE TERAPEUTICO.
2. EN MOMENTO DE HABLAR CON LA PACIENTE SE EVIDENCIA AFECTO PLANO, AL PARECER CON POBRE COMPRENSION DE LA SITUACIÓN ACTUAL TANTO DE ELLA COMO SU BEBE. SI MANIFESTACION DE PREOCUPACIONES O DUDAS. SE CONSDERA PERTINENTE VALORACION POR PSIQUIATRIA PARA EVALUAR CONDICION DE BASE QUE PUDIESE EXPLICAR COMPORTAMIENTO.

SE TRATA DE PACIENTE CON ALTO RIESGO DE COMPLICACION MATERNA Y FETAL CON ALTO RIESGO DE MORTALIDAD TANTO MATERNA COMO FETAL. HASTA AHORA CON INDICACION DE MANEJO EXPECTANTE HASTA 28 SEMANAS SIN CONDICIONES MATERNAS Y FETALES LO PERMITEN. SE INDICA CONTINUAR EN MANEJO CONJUNTO CON MONITORIA UCIN. CON MONITORIA CONTINUA DE SIGNOS VITALES Y FETOCARDIA SE CONTINUARA MANEJO EXPECTANTE DE ACUERDO A EVOLUCION.
SE HABLA EN CONJUNTO CON RESTO DE ESPECIALIDADES (CARDIOLOGIA, NEONATOLOGIA Y GINECOLOGIA) CON LA PACIENTE, SE PLANTEAN POSIBILIDADES DE MANEJO Y PRONOSTICOS TANTO MATERNOS COMO FETALES. POR EL MOMENTO

NOTAS MÉDICAS

ACEPTA MANEJO EXPECTANTE ESTRICTO PROPUESTO.

Plan de manejo: PLAN DE MANEJO:
MONITORIA UCIN
. TERAPIA RESPIRATORIA CADA 6 HORAS
. TERAPIA FÍSICA CADA 12 HORAS
. REHABILITACIÓN CARDIACA
. GLUCOMETRIAS CADA 12 HORAS
. DIETA LÍQUIDA ESPESA
. RESTRICCIÓN HÍDRICA DE 1200 CC

MEDICAMENTOS:
- ENOXAPARINA 60 MG SC CADA 12 HORAS
- BISOPROLOL 10 MG VO CADA 24 HORAS
- FUROSEMIDA 20 MG IV CADA 6 HORAS
- LORAZEPAM 0. 5 MG CADA NOCHE

EN PROCESO
- ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA POR GINECOLOGÍA CADA 72 HORAS (EVALUAR PRESENCIA DE OLIGOAMNIOS)
- PRO BNP CADA 72 H
- LLEVAR A JUNTA CARDIOVASCULAR EL 21/02/25
- SEGUIMIENTO POR GINECOLOGÍA, CARDIOLOGÍA

Justificación de permanencia en el servicio: PACIENTE CON ALTO RIESGO DE COMPLICACION.

--REGISTRO PENDIENTE DE AVAL--

Fecha: 19/02/2025 14:00 - Ubicación: UCI CARDIOVASCULAR
Evolución médica - Apoyo - CARDIOLOGIA

Condiciones del paciente: Materna
Gesta: 1

ANAMNESIS
Subjetivo: CARDIOLOGIA CLINICA
Objetivo: TA: 108/86 FC 88 F: 16

EXAMEN FÍSICO
Escala del dolor: 0

Diagnósticos activos después de la nota Diagnóstico principal - I519 - ENFERMEDAD CARDIACA NO ESPECIFICADA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, R060 - DISNEA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, Z358 - SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, I050 - ESTENOSIS MITRAL, Fecha de diagnóstico: 18/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses.

ANÁLISIS DEL CASO Y PLAN DE MANEJO

Análisis: Paciente conocida con estenosis mitral reumática severa sintomática y embarazo de 24 semanas que con la progresión de la gestación ha empeorado la manifestación clínica de la valvulopatía. La paciente no aceptó interrupción del embarazo. Actualmente en mejor estado general con el inicio de terapia diurética y el betabloqueador. La encontramos en cama, tranquila, sin requerimiento de suplemento de oxígeno, sin agregados pulmonar. Control de Pro BNP en 484 (sin variación con respecto al previo), con plan de continuar seguimiento cada 72 horas de laboratorios. Debe continuar monitorea obstetrica y fetal por parte de Ginecologia (ecografia obstetrica cada 72 horas)

Plan de manejo: Se continua igual dosis de diuretico y b bloqueador
Seguimiento pro ginecologia.

NOTAS MÉDICAS

Justificación de permanencia en el servicio: Requiere seguimiento en UCIN.

Fecha: 19/02/2025 21:45 - Ubicación: UCI CARDIOVASCULAR
Evolución médica - MEDICO INTENSIVISTA

Condiciones del paciente: Materna
Gesta: 1

ANAMNESIS
Subjetivo: **EVOLUCIÓN UCI CARDIOVASCULAR**

FI HUV: 10/02/25
FI UCI CV: 17/02/25

DIAGNÓSTICOS:
1. Estenosis mitral grave de origen reumático
2. G1P0
 - Embarazo 24. 4 semanas
3. Alta probabilidad de hipertensión pulmonar

PROBLEMAS
Riesgo de colapso cardiovascular
Gestación de alto riesgo

Objetivo: EXAMEN FÍSICO:
SIGNOS VITALES
TA: 103/64 mmHg
TAM: 77 mmHg
FC: 94 Lpm
T°: 36. 1°C
Peso: 53 Kg

CARDIOVASCULAR: Ruidos cardiacos rítmicos. R1 reforzado con soplo mesodiastólico foco mitral.

RESPIRATORIO: Campos pulmonares, sin sobreagregados. Sin soporte de oxígeno, FR 22 rpm StO2 99%

GASTROINTESTINAL: Útero grávido, AU 22 ccm, movimientos fetales presentes, FCF 143 lpm.
Fecha de última deposición: Desconocida

METABÓLICO: Tolera VO
Glucometria: 90-207 mg/dL

INFECCIOSO: Afebril sin sangrados externos

RENAL: Diuresis espontánea,
GU:3. 3 cc/k/h 12 h balance dia -1650 cc.
Acumulado -2500 cc

EXTREMIDADES: Pulsos ++, móviles, sin edema

SNC: Alerta, consciente, colaborador, Glasgow 15/15

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	

NOTAS MÉDICAS

EXAMEN FÍSICO
Escala del dolor: 0.

Diagnósticos activos después de la nota Diagnóstico principal - I519 - ENFERMEDAD CARDIACA NO ESPECIFICADA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, R060 - DISNEA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, Z358 - SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, I050 - ESTENOSIS MITRAL, Fecha de diagnóstico: 18/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses.

ANÁLISIS DEL CASO Y PLAN DE MANEJO

Análisis: ***ANALISIS**
Paciente con diagnosticos conocidos. En el momento:
-Condicion clinica: Aceptable
- Hemodinamico: estable. Cifras tensionales optimas, FC en ritmo sinusal; sin emabrgo feura de meta que requiere la paciente. Hoy valora cardiologica e indica conitnua con igual plan de manejo. No modifica dosis de BB
- Respiratorio: sin soporte de oxigeno. mecanica respiratoria optima. Sin disnea ni dificultad respiratoria.
- Afebril. sin SIRS activos. Direusis optima. Tolera via oral. Glucometrias en meta.
- Neurologico: sin deficit agudo. Sin emabrgo con crisis de ansiedad en manejo con benzodiacepina indicada por psiquiatria.
Paciente con riesgo de complicaciones mayores. Continuamos manejo integral en la unidad.

Plan de manejo: Sin cambios por el momento

Justificación de permanencia en el servicio: UCIN
Monitoreo hemodinamico continuo
Alto reisgo de complicaciones cardiovasculares.

Fecha: 19/02/2025 23:39 - Ubicación: UCI CARDIOVASCULAR
Evolución médica - GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Condiciones del paciente: Materna
Gesta: 1

ANAMNESIS
Subjetivo:

DIAGNÓSTICOS DE MANEJO:
1. G1P0
2. EMBARAZO DE 24, 6 SEMANAS POR ECOGRAFÍA 12/11/2024 10. 5
3. DISNEA EN ESTUDIO
3. 1. ESTENOSIS MITRAL SEVERA DE ORIGEN REUMÁTICO
3. 2. ALTA PROBABILIDAD DE HIPERTENSIÓN PULMONAR
Objetivo: -

EXAMEN FÍSICO
Escala del dolor: 0

Examen Físico:
Cabeza
Cuero cabelludo : SIGNOS VITALES: TA: 115/68 MMHG, // FC: 81 LPM, // FR: 18 RPM, // T°: 36°C, // SO2: 96% CON REQUERIMIENTO DE OXIGENO POR CANULA 1L/MIN.
BUENAS CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, CONJUNTIVAS PÁLIDAS, ROSADAS
C/P RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS SOPLO HOLOSISTÓLICO EN FOCO MITRAL, MV CONSERVADO SIN SOBREAGREGADOS
ABDOMEN ÚTERO GRÁVIDO, AU: 22 CM, FUVCDI, MOVIMIENTOS FETALES PRESENTES, NO ACTIVIDAD UTERINA, NO DOLOR FCF: 145 LPM
G/U SIN SANGRADO, NO AMNIORREA, SE OMITE TV
LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS.

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	

NOTAS MÉDICAS

DIURESIS ESPONTÁNEA NO CUANTIFICADA.

Diagnósticos activos después de la nota Diagnóstico principal - I519 - ENFERMEDAD CARDIACA NO ESPECIFICADA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, R060 - DISNEA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, Z358 - SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, I050 - ESTENOSIS MITRAL, Fecha de diagnóstico: 18/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses.

ANÁLISIS DEL CASO Y PLAN DE MANEJO

Análisis: PACIENTE DE 20 AÑOS G1P0 CON EMBARAZO DE 24, 6 SEMANAS, HOSPITALIZADA EN CONTEXTO DE:

1. ESTENOSIS MITRAL SEVERA DE ORIGEN REUMATICA: HISTORIA DE DISMINUCION DE LA CLASE FUNCIONAL, CON ECO TE 14/02/2025 CON ENFERMEDAD REUMÁTICA DE LA VÁLVULA MITRAL, CON ESTENOSIS DE GRADO SEVERO E INSUFICIENCIA DE GRADO LEVE, DILATACIÓN SEVERA DE LA AURÍCULA IZQUIERDA. Y ALTA PROBABILIDAD DE HIPERTENSIÓN PULMONAR CON PROBNP DE 484. VALORADA POR:
1. JUNTA CARDIOQUIRURGICA + MATERNOFETAL: CON INDICACION DE MANEJO EXPEXTANTE HASTA LAS 28 SEMANAS, FINALIZACION POR CESAREA Y EN MISMO TIEMPO QUIRURGICO CORRECCION DE VALVULA. CON ECO TE CON SCORE DE WILKINS DESFAVORABLE PARA INTERVENCION CON VALVULOTOMIA. CON PLAN DE REEMPLAZO VALVULAR ABIERTO O EN CASO EXTREMO VALVULOTOMIA CON BALON PERCUTANEO CON RESLPADO DE CX CARDIOVASCULAR CON LOS RIESGOS QUE IMPLICA EL PROCEDIMIENTO CON SCORE DE WILKINS DESFAVORABLE. AHORA EN MANEJO CON BISOPROLOL, FUROSEMIDA Y ANTICOAGULACION. EN EL MOMENTO CON ESTABILIDAD HEMODINAMICA.
SE CONSIDERA PACIENTE CON EMBARAZO EN LIMITE DE VIABILIDAD.

SE TRATA DE PACIENTE CON ALTO RIESGO DE COMPLICACION MATERNA Y FETAL CON ALTO RIESGO DE MORTALIDAD TANTO MATERNA COMO FETAL. SE INDICA CONTINUAR EN MANEJO CONJUNTO CON MONITORIA UCIN. CON MONITORIA CONTINUA DE SIGNOS VITALES Y FETOCARDIA SE CONTINUARA MANEJO EXPECTANTE DE ACUERDO A EVOLUCION.
SE HABLA EN CONJUNTO CON RESTO DE ESPECIALIDADES (CARDIOLOGIA, NEONATOLOGIA Y GINECOLOGIA) CON LA PACIENTE, SE PLANTEAN POSIBILIDADES DE MANEJO Y PRONOSTICOS TANTO MATERNOS COMO FETALES. POR EL MOMENTO ACEPTA MANEJO EXPECTANTE ESTRICTO PROPUESTO.

Plan de manejo: SIN CAMBIOS POR PARTE DE LA ESPECIALIDAD

Justificación de permanencia en el servicio:.

--REGISTRO PENDIENTE DE AVAL--

Fecha: 20/02/2025 08:33 - Ubicación: UCI CARDIOVASCULAR
Evolución médica - MEDICO INTENSIVISTA

Condiciones del paciente: Materna
Gesta: 1

ANAMNESIS
Subjetivo: formulacion
Objetivo:.

EXAMEN FÍSICO
Escala del dolor: 0.

Diagnósticos activos después de la nota Diagnóstico principal - I519 - ENFERMEDAD CARDIACA NO ESPECIFICADA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, R060 - DISNEA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, Z358 - SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, I050 - ESTENOSIS MITRAL, Fecha de diagnóstico: 18/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses.

ANÁLISIS DEL CASO Y PLAN DE MANEJO

Análisis:.

Plan de manejo:.

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	

NOTAS MÉDICAS

Justificación de permanencia en el servicio:.

Fecha: 20/02/2025 10:38 - Ubicación: UCI CARDIOVASCULAR
Evolución médica - GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Condiciones del paciente: Materna
Gesta: 1

DIAGNÓSTICOS
1. G1P0
2. EMBARAZO DE 25 SEMANAS POR ECOGRAFÍA 12/11/2024 10. 5
3. DISNEA EN ESTUDIO
 3. 1. ESTENOSIS MITRAL SEVERA DE ORIGEN REUMÁTICO
 3. 2. ALTA PROBABILIDAD DE HIPERTENSIÓN PULMONAR

PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN NO HA PRESENTADO NUEVA SINTOMATOLOGÍA. AHORA SIN DISNEA. SIN DOLOR PRECORDIAL. SIN OTRA SINTOMATOLOGIA ASOCIADA.

Objetivo: SIGNOS VITALES: TA: 115/68 MMHG, // FC: 78 LPM, // FR: 18 RPM, // T°: 36°C, // SO2: 96% SIN OXIGEMO
BUENAS CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL, CONJUNTIVAS PÁLIDAS, ROSADAS
C/P RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS SOPLO HOLOSISTÓLICO EN FOCO MITRAL, MV CONSERVADO SIN SOBREAGREGADOS
ABDOMEN ÚTERO GRÁVIDO, AU: 22 CM, FUVCDI, MOVIMIENTOS FETALES PRESENTES, NO ACTIVIDAD UTERINA, NO DOLOR FCF: 154 LPM
G/U SIN SANGRADO, NO AMNIORREA, SE OMITE TV
LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS.
DIURESIS ESPONTÁNEA NO CUANTIFICADA

EXAMEN FÍSICO
Escala del dolor: 0.

Diagnósticos activos después de la nota Diagnóstico principal - I519 - ENFERMEDAD CARDIACA NO ESPECIFICADA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, R060 - DISNEA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, Z358 - SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, I050 - ESTENOSIS MITRAL, Fecha de diagnóstico: 18/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses.

ANÁLISIS DEL CASO Y PLAN DE MANEJO

Análisis: PACIENTE DE 20 AÑOS G1P0 CON EMBARAZO DE 25 SEMANAS, HOSPITALIZADA EN CONTEXTO DE:

1. ESTENOSIS MITRAL SEVERA DE ORIGEN REUMATICA: HISTORIA DE DISMINUCION DE LA CLASE FUNCIONAL, CON ECO TE 14/02/2025 CON ENFERMEDAD REUMÁTICA DE LA VÁLVULA MITRAL, CON ESTENOSIS DE GRADO SEVERO E INSUFICIENCIA DE GRADO LEVE, DILATACIÓN SEVERA DE LA AURÍCULA IZQUIERDA. Y ALTA PROBABILIDAD DE HIPERTENSIÓN PULMONAR VALORADA POR:

1. JUNTA CARDIOQUIRURGICA + MATERNOFETAL: PACIENTE CON ESTENOSIS MITRAL REUMATICA SEVERA SINTOMATICA CON EMPEORAMIENTO DE SINTOMATOLOGIA POR PROGRESION DE LA GESTACION. CON INDICACION DE MANEJO EXPEXTANTE HASTA LAS 28 SEMANAS, FINALIZACION POR CESAREA Y EN MISMO TIEMPO QUIRURGICO CORRECCION DE VALVULA. CON ECO

NOTAS MÉDICAS

TE CON SCORE DE WILKINS DESFAVORABLE PARA INTERVENCION CON VALVULOTOMIA. CON PLAN DE REEMPLAZO VALVULAR ABIERTO O EN CASO EXTREMO VALVULOTOMIA CON BALON PERCUTANEO CON RESLPADO DE CX CARDIOVASCULAR. AHORA EN MANEJO CON BISOPROLOL, FUROSEMIDA Y ANTICOAGULACION. EN EL MOMENTO CON ESTABILIDAD HEMODINAMICA. SV ESTABLES ASINTOMATICA.

POR PARTE DE CARDIOLOGIA CON INDICACION DE SEGUIMIENTO CON ECOGRAFIA OBSTETRICA CADA 72 HORAS PARA DESCARTAR OLIGOAMNIOS Y GUIAR TERAPIA DIURETICA. SE CONSIDERA PACIENTE CON EMBARAZO EN LIMITE DE VIABILIDAD. SE INDICA POR PARTE DE PERINATOLOGIA RASTREO ECOGRAFICO EN CASO DE SER NECESARIO. Y EN CASO DE REQUERIR ECOGRAFIA FORMAL DEBERA REALIZARSE EN SEPTIMO PISO CON EQUIPOS PARA BIOMETRIA FETAL. SIN EMBARGO, DADA EDAD GESTACIONAL CON POCAS HERRAMIENTAS PARA OFRECER EN CASO DE OLIHGOHIDRAMNIOS DONDE DADO ALTO RIESGO DE COMPLICACION MATERNA SE DEBERA EVALUAR RIESGO BENEFICIO DE AJUSTE TERAPEUTICO.
2. EN MOMENTO DE HABLAR CON LA PACIENTE SE EVIDENCIA AFECTO PLANO, AL PARECER CON POBRE COMPRENSION DE LA SITUACIÓN ACTUAL TANTO DE ELLA COMO SU BEBE. SI MANIFESTACION DE PREOCUPACIONES O DUDAS. SE CONSIDERO PERTINENTE VALORACION POR PSIQUIATRIA REALIZADA EL DIA DE AYER QUIENES CONSIDERAN NO HAY UN COMPROMISO EN EL JUICIO PARA LA TOMA DE DECISIONES MEDICAS. POR AFECTO CON TENDENCIA A ANSIEDAD INDICARON MANEJO CON LORAZEPAM. POR LO DEMAS CONTINUA IGUAL.

SE TRATA DE PACIENTE CON ALTO RIESGO DE COMPLICACION MATERNA Y FETAL CON ALTO RIESGO DE MORTALIDAD TANTO MATERNA COMO FETAL. HASTA AHORA CON INDICACION DE MANEJO EXPECTANTE HASTA 28 SEMANAS SIN CONDICIONES MATERNAS Y FETALES LO PERMITEN. SE INDICA CONTINUAR EN MANEJO CONJUNTO CON MONITORIA UCIN. CON MONITORIA CONTINUA DE SIGNOS VITALES Y FETOCARDIA SE CONTINUARA MANEJO EXPECTANTE DE ACUERDO A EVOLUCION.
SE HABLA EN CONJUNTO CON RESTO DE ESPECIALIDADES (CARDIOLOGIA, NEONATOLOGIA Y GINECOLOGIA) CON LA PACIENTE, SE PLANTEAN POSIBILIDADES DE MANEJO Y PRONOSTICOS TANTO MATERNOS COMO FETALES. POR EL MOMENTO ACEPTA MANEJO EXPECTANTE ESTRICTO PROPUESTO.

Plan de manejo: PLAN DE MANEJO:
MONITORIA UCIN
. TERAPIA RESPIRATORIA CADA 6 HORAS
. TERAPIA FÍSICA CADA 12 HORAS
. REHABILITACIÓN CARDIACA
. GLUCOMETRIAS CADA 12 HORAS
. DIETA LÍQUIDA ESPESA
. RESTRICCIÓN HÍDRICA DE 1200 CC

MEDICAMENTOS:
- ENOXAPARINA 60 MG SC CADA 12 HORAS
- BISOPROLOL 10 MG VO CADA 24 HORAS
- FUROSEMIDA 20 MG IV CADA 6 HORAS
- LORAZEPAM 0. 5 MG CADA NOCHE

EN PROCESO
- ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA POR GINECOLOGÍA CADA 72 HORAS (EVALUAR PRESENCIA DE OLIGOAMNIOS)
- PRO BNP CADA 72 H
- LLEVAR A JUNTA CARDIOVASCULAR EL 21/02/25
- SEGUIMIENTO POR GINECOLOGÍA, CARDIOLOGÍA

Justificación de permanencia en el servicio: SEGUIMIENTO.

Fecha: 20/02/2025 11:59 - Ubicación: UCI CARDIOVASCULAR
Evolución médica - Apoyo - MEDICO INTENSIVISTA

Condiciones del paciente: Materna
Gesta: 1

ANAMNESIS
Subjetivo: **EVOLUCIÓN UCI CARDIOVASCULAR**

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	

NOTAS MÉDICAS

FI HUV: 10/02/25
FI UCI CV: 17/02/25

DIAGNÓSTICOS:
1. Estenosis mitral grave de origen reumático
2. G1P0
 - Embarazo 24. 6 semanas
3. Alta probabilidad de hipertensión pulmonar

PROBLEMAS
Riesgo de colapso cardiovascular
Gestación de alto riesgo

ESCALAS
. Ideación suicida: 0 puntos
. APACHE II: 3 puntos, mortalidad 4%
. SOFA DIA 1 (18. 02. 25): 0 puntos
. SOFA DIA 2 (19. 02. 25): 1 punto mortalidad 0%
. SOFA DIA 3 (20. 02. 25): 1 punto mortalidad 0%

Objetivo: **EVOLUCIÓN UCI CARDIOVASCULAR**

FI HUV: 10/02/25
FI UCI CV: 17/02/25

DIAGNÓSTICOS:
1. Estenosis mitral grave de origen reumático
2. G1P0
 - Embarazo 24. 6 semanas
3. Alta probabilidad de hipertensión pulmonar

PROBLEMAS
Riesgo de colapso cardiovascular
Gestación de alto riesgo

ESCALAS
. Ideación suicida: 0 puntos
. APACHE II: 3 puntos, mortalidad 4%
. SOFA DIA 1 (18. 02. 25): 0 puntos
. SOFA DIA 2 (19. 02. 25): 1 punto mortalidad 0%
. SOFA DIA 3 (20. 02. 25): 1 punto mortalidad 0%

EXAMEN FÍSICO
Escala del dolor: 0.

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	

NOTAS MÉDICAS

Diagnósticos activos después de la nota Diagnóstico principal - I519 - ENFERMEDAD CARDIACA NO ESPECIFICADA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, R060 - DISNEA, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, Z358 - SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO, Fecha de diagnóstico: 10/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses, I050 - ESTENOSIS MITRAL, Fecha de diagnóstico: 18/02/2025, Edad al diagnóstico: 20 Años y 9 meses.

ANÁLISIS DEL CASO Y PLAN DE MANEJO

Análisis: Análisis 20/02/2025
Paciente de 20 años de edad sin antecedentes de importancia, cursando con embarazo de 24. 6 con Eco TE que evidencia Enfermedad reumática de la válvula mitral, con estenosis de grado severo e insuficiencia de grado leve y probabilidad alta de Hipertensión Pulmonar, evolución clínica estacionaria en vigilancia UCIN con los siguientes problemas.
. Paciente hemodinámicamente estable, sin soporte vasopresor, en manejo betabloqueador con bisoprolol con FC en metas. Continuamos manejando expectante hasta las 28 ss.
. Sin soporte de oxígeno, sin disnea, saturaciones adecuada.
. Tolera VO con glucometría en metas.
. Diuresis espontánea en manejo con diurético de asa a 20mg cada 6 horas. Azoados normales con hiponatremia leve, que no amerita corrección.
. En el momento afebril, no leucocitosis, sin indicación de manejo antibiótico.
. Feto en buenas condiciones, sin sufrimiento, seguimiento por G/O.
. Anemia leve, leucocitos y plts en normalidad con indicación de anticoagulación con heparinas de BPM

Paciente con Estenosis Mitral Severa con adecuada evolución, estable hemodinámicamente, continua monitorización UCIN por riesgo de descompensación hemodinámica y riesgo de muerte fetal. Se explica conducta a paciente y familiar quien refiere entender y aceptar.

Plan de manejo: PLAN DE MANEJO:
MONITORIA UCIN
. Terapia respiratoria cada 6 horas
. Terapia física cada 12 horas
. Rehabilitación cardiaca
. Glucometrias cada 12 horas
. Dieta líquida espesa
. Restricción hídrica de 1200 cc

MEDICAMENTOS:
- Enoxaparina 60 Mg Sc Cada 12 Horas
- Bisoprolol 10 Mg Vo Cada 24 Horas
- Furosemida 20 mg IV cada 6 horas
- Lorazepam 0. 5 mg cada noche

EN PROCESO
- Ecografía obstétrica por ginecología cada 72 horas (evaluar presencia de oligoamnios) (Diferida por Ginecobstetricia)
- Pro Bnp cada 72 h
- Llevar a junta cardiovascular el 21/02/25
- Seguimiento por ginecología, cardiología

METAS
*EVA -4
* TAM > 65 mmHg.
* FC entre <70 lpm
* SaO2 mayor a 90%
* Diuresis 1. 0 cc/kg/hora
* T° 36 - 37. 5°C
* Glucometrias entre 140 y 180 mg/dl
* Lactato < 2 mmol/dl
* Potasio entre 3. 8 y 4. 5 mmol /dl
* Fósforo entre 2. 5 y 3. 5 mmol/dl
* Hb > 9 gr/dl
* Plaquetas > 100. 000

Justificación de permanencia en el servicio: UCIN
Riesgo de colapso cardiovascular
Gestación de alto riesgo
Monitoroe hemodinamico conitnuo.

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

Fecha: 17/02/2025 16:59 - Ubicación: ALTO RIESGO OBSTETRICO
Registro de documentos - MEDICO INTENSIVISTA

Fecha: 17/02/2025 17:01 - Ubicación: ALTO RIESGO OBSTETRICO
Registro de documentos - MEDICO INTENSIVISTA

Fecha: 19/02/2025 14:15 - Ubicación: UCI CARDIOVASCULAR
Trabajo social - Interconsultante - TRABAJO SOCIAL

Causa externa: ENFERMEDAD GENERAL

Condiciones del paciente: Materna

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA
Religión: CATOLICA

INFORMACIÓN FAMILIAR

Nombres	Apellidos	Edad (años)	Parentesco	Ocupación	Estado civil	Escolaridad	Vive con el paciente	Teléfono	Observaciones
			MADRE	AMA DE CASA		Primaria	No		

INFORMACIÓN ACADÉMICA, LABORAL Y ECONÓMICA
Escolaridad: Basica Secundaria Ocupación: AMA DE CASA

ANÁLISIS DEL CASO
Análisis psicosocial: Interconsulta por Trabajo Social de la paciente , identificada con cédula . UCI Cardiovascular

Se realiza valoración sociofamiliar con la señora , madre de la paciente, quien comenta que el día de hoy llegó a Cali, menciona que tiene contacto diariamente con su hija pero es la primera vez que viaja a la ciudad, por ende, desconoce información sobre los datos de ubicación. La paciente es oriunda de , desde hace dos años, vive en Cali/Valle.

Su escolaridad es técnico en auxiliar de enfermería.

La paciente convive con su pareja sentimental, el señor , y la familia del joven. La pareja es el proveedor económico. Respecto a su grupo familiar de origen, el padre vive en , la madre vive en con hermano menor, y sus otras dos hermanas viven en . Entre el grupo familiar mantiene comunicación.

Se evidencia comprensión sobre la condición clínica de la paciente. Manifiesta que estará acompañando a la paciente durante la estancia hospitalaria. Comenta sobre las dificultades económicas para su permanencia en la ciudad.

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	

OTRAS NOTAS

Se identifica paciente adulta joven con diagnósticos anotados en historia clínica, pertenece a medio familiar extenso. Su red de apoyo se muestra dispuesta en acompañar el proceso hospitalario. Familia con bajos recursos económicos. En la intervención se brinda orientación sobre la participación de la red de apoyo en el proceso hospitalario. Además, la necesidad de un acompañamiento de calidad a la paciente. Se explican las condiciones y normas del hogar de paso y se solicita cupo. Se promueve la comunicación clara y respetuosa con el personal asistencial que le permita tener mayor comprensión de la condición clínica de la paciente. Y se socializan derechos y deberes, normas del servicio, canales para radicar PQRSF. La sra Maria refiere comprender.